

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Amenorreas Primarias y Secundarias

Subtema: Síndrome de insensibilidad completa a andrógenos

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 16 años consulta por ausencia de menarca. Tiene desarrollo mamario Tanner V, vello púbico escaso, talla de 178 cm y genitales externos femeninos sin útero visible por ultrasonido. La resonancia identifica gónadas inguinales bilaterales y el cariotipo es 46,XY. No hay dolor cíclico ni exposición a estrógenos exógenos.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta que equilibra mejor el riesgo oncológico gonadal y el desarrollo puberal ya completado?

- A. Gonadectomía bilateral inmediata antes de consejería
- B. Conservación gonadal indefinida con ultrasonido semestral
- C. Gonadectomía bilateral posterior a la pubertad con reemplazo estrogénico *
- D. Biopsia gonadal anual y progestágeno cíclico

Explicación: El fenotipo, ausencia de útero y 46,XY indican insensibilidad completa a andrógenos. Las gónadas producen estrógenos periféricos que permitieron la pubertad; después de completarla se recomienda gonadectomía por aumento progresivo de riesgo tumoral y reemplazo estrogénico posterior.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Amenorreas Primarias y Secundarias

Subtema: Síndrome de Rokitansky

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 18 años con telarquía y pubarquía normales nunca ha menstruado. Refiere coito imposible por canal vaginal corto. Ultrasonido pélvico demuestra ovarios normales y ausencia de útero; el cariotipo es 46,XX. No presenta cefalea, galactorrea ni cólicos mensuales.

Pregunta: ¿Qué intervención inicial es la más apropiada para restaurar función sexual?

- A. Histerectomía profiláctica y dilatación vaginal
- B. Dilatación vaginal progresiva acompañada de apoyo psicosocial *
- C. Anticonceptivo combinado durante seis meses
- D. Resección laparoscópica de bandas müllerianas

Explicación: La agenesia mülleriana con ovarios funcionales causa amenorrea primaria y vagina corta. La primera opción para crear una neovagina funcional es dilatación progresiva guiada, con consejería sobre fertilidad y apoyo psicosocial; la cirugía se reserva para fracaso o preferencia informada.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrados Uterinos Anormales de Origen No Anatómico

Subtema: Coagulopatía por enfermedad de von Willebrand

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 24 años con sangrado menstrual de 10 días desde la menarca, ferritina de 7 ng/mL y epistaxis recurrente. Ultrasonido transvaginal sin lesiones estructurales; TSH normal. Su madre requirió transfusión tras una extracción dental. Está hemodinámicamente estable y desea anticoncepción.

Pregunta: ¿Cuál es el abordaje más congruente con la sospecha etiológica?

- A. Endometriectomía por sangrado refractario
- B. Solicitar evaluación de hemostasia y tratar el sangrado con opción hormonal o antifibrinolítica *
- C. Legrado uterino diagnóstico como primera medida
- D. Histerectomía subtotal para prevenir anemia

Explicación: La menorragia desde la menarca, ferropenia y antecedentes de sangrado mucocutáneo orientan a coagulopatía, especialmente von Willebrand. Se requiere estudio de hemostasia coordinado y control del sangrado con anticoncepción hormonal o ácido tranexámico según el caso, evitando procedimientos irreversibles.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrados Uterinos de Origen Desconocido

Subtema: Síndrome de ovario poliquístico

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 29 años, IMC 34 kg/m², presenta intervalos menstruales de 70 a 120 días, hirsutismo progresivo y acantosis. Prueba de embarazo negativa; TSH y prolactina normales. Ultrasonido muestra ovarios con aumento de volumen y múltiples folículos periféricos. No desea embarazo durante el siguiente año.

Pregunta: ¿Qué medida reduce de forma más directa el riesgo endometrial asociado a su patrón ovulatorio?

- A. Metformina como único tratamiento, sin regulación menstrual
- B. Anticonceptivo hormonal combinado si no existen contraindicaciones *
- C. Clomifeno continuo hasta obtener menstruación mensual
- D. Aspirina diaria por resistencia a la insulina

Explicación: El SOP con anovulación crónica expone al endometrio a estrógeno sin oposición. En quien no busca gestación, el anticonceptivo combinado regula ciclos, proporciona progestágeno endometrial y mejora hiperandrogenismo; el descenso ponderal y la valoración metabólica son complementarios.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrados Uterinos de Origen Desconocido

Subtema: Endometriosis profunda

Dificultad: alta

Caso clínico: Paciente de 35 años con infertilidad de tres años, dismenorrea incapacitante, disquecia cíclica y dolor profundo con coito. Ultrasonido especializado muestra nódulo rectovaginal de 2.5 cm y endometrioma izquierdo de 5 cm; reserva ovárica disminuida. Desea embarazo pronto.

Pregunta: ¿Cuál es la recomendación más individualizada antes de decidir cirugía ovárica?

- A. Suprimir ovulación por dos años con agonista de GnRH
- B. Valorar reproducción asistida y evitar cirugía rutinaria que disminuya más la reserva *
- C. Indicar anticonceptivo combinado hasta desaparición del endometrioma
- D. Realizar histerectomía con ooforectomía bilateral

Explicación: La endometriosis profunda con endometrioma y baja reserva exige consejería reproductiva. La cirugía repetida o rutinaria del endometrioma puede reducir reserva ovárica; se individualiza con reproducción asistida, dolor, acceso folicular y sospecha de malignidad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología, Menopausia y Climaterio

Subtema: Terapia hormonal menopáusica

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 52 años, amenorrea de 14 meses, sofocos intensos y despertares nocturnos. Conserva útero, no tiene trombosis, hepatopatía, cáncer de mama ni sangrado posmenopáusico. IMC 23 kg/m², mamografía reciente normal. Solicita una opción eficaz para síntomas vasomotores.

Pregunta: ¿Qué esquema es el más apropiado?

- A. Estrógeno sistémico sin progestágeno
- B. Estrógeno sistémico combinado con progestágeno *
- C. Tibolona en presencia de sangrado sin estudiar
- D. Raloxifeno para aliviar sofocos

Explicación: En una mujer sintomática cercana a la menopausia sin contraindicaciones, la terapia hormonal puede utilizarse tras decisión informada. Si conserva útero, el progestágeno es indispensable junto con estrógeno sistémico para prevenir hiperplasia y cáncer endometrial.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología, Menopausia y Climaterio

Subtema: Incontinencia urinaria de esfuerzo

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 57 años con escapes al toser, correr y levantar peso; niega urgencia, ardor o pérdida nocturna. Prueba de esfuerzo con vejiga llena es positiva y no hay prolapso apical significativo. No desea cirugía inicialmente.

Pregunta: ¿Cuál es la primera intervención terapéutica razonable?

- A. Antimuscarínico de acción prolongada
- B. Entrenamiento vesical exclusivo
- C. Ejercicios supervisados de músculos del piso pélvico *
- D. Cateterismo intermitente programado

Explicación: La pérdida coincidente con incremento de presión intraabdominal define incontinencia de esfuerzo. El entrenamiento de músculos del piso pélvico es primera línea, junto con modificaciones de peso y hábitos; antimuscarínicos corresponden a urgencia y el cateterismo no trata este mecanismo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrados Uterinos Anormales de Origen Anatómico No Maligno

Subtema: Miomatosis submucosa

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 41 años, sin deseo reproductivo inmediato, presenta menorragia, anemia de 8.9 g/dL y presión pélvica.

Ultrasonido con mioma submucoso FIGO 1 de 3 cm y cavidad distorsionada, sin otros miomas relevantes. Tras hierro oral persiste sangrado limitante.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención que mejor dirige la lesión causal?

- A. Miomectomía histeroscópica *
- B. Miomectomía abdominal para todos los miomas
- C. Ablación endometrial sin resección de mioma
- D. Antibiótico de amplio espectro por siete días

Explicación: El mioma submucoso FIGO 0 o 1 es una causa directa de sangrado y es accesible por histeroscopia. La resección histeroscópica trata la distorsión intracavitaria y preserva útero; la ablación aislada es menos adecuada si persiste la lesión.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrados Uterinos Anormales de Origen Anatómico No Maligno

Subtema: Torsión ovárica

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 27 años llega con dolor súbito unilateral intenso, náusea y vómito de 5 horas. Tiene quiste ovárico de 7 cm; Doppler muestra flujo arterial ovárico conservado pero aumento de volumen y folículos periféricos. Prueba de embarazo negativa y sin fiebre.

Pregunta: ¿Qué conducta evita perder una gónada potencialmente viable?

A. Alta con analgésicos por conservarse flujo arterial

B. Laparoscopia urgente con detorsión y manejo conservador *

C. Ooforectomía obligatoria sin explorar viabilidad

D. Anticoagulación y ultrasonido en 48 horas

Explicación: El flujo Doppler conservado no excluye torsión, por doble irrigación y torsión intermitente. El cuadro y masa anexial requieren laparoscopia urgente; la detorsión y cistectomía conservadora son preferibles aun si el ovario tiene aspecto violáceo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología Ginecológica

Subtema: Tamizaje de cáncer cervicouterino

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 35 años, asintomática, inmunocompetente, sin antecedente de lesión cervical, pregunta por el método de tamizaje. Tiene vida sexual activa, su última citología fue hace seis años y hoy no está embarazada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia de tamizaje es adecuada en este grupo de edad?

A. Citología anual obligatoria de por vida

B. Prueba de VPH de alto riesgo conforme al programa de tamizaje *

C. Colposcopia directa aunque no haya prueba anormal

D. Marcadores tumorales séricos anuales

Explicación: En mujeres de 35 a 64 años el programa mexicano prioriza detección de VPH de alto riesgo y triage de resultados positivos. La colposcopia no es una prueba de tamizaje inicial en una paciente sin resultado anormal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología Ginecológica

Subtema: Cáncer de endometrio

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 63 años, con obesidad y diabetes, consulta por sangrado transvaginal nuevo un año después de la menopausia. No usa terapia hormonal. Ultrasonido endovaginal muestra endometrio homogéneo de 9 mm. Se encuentra estable y exploración sin lesión cervical evidente.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico más indicado?

- A. Repetir ultrasonido en un año
- B. Biopsia endometrial para descartar neoplasia *
- C. Iniciar progestágeno sin toma de tejido
- D. Solicitar CA-125 como prueba confirmatoria

Explicación: Todo sangrado posmenopáusico requiere evaluación de neoplasia endometrial. Un grosor endometrial mayor de 4 mm obliga a obtener muestra histológica, usualmente por biopsia endometrial; CA-125 no sustituye la confirmación tisular.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Mamaria Benigna

Subtema: Mastitis puerperal

Dificultad: alta

Caso clínico: Puérpera de 12 días con dolor focal, eritema triangular y fiebre de 38.7 C en mama derecha. Conserva buen estado general, no hay fluctuación y el recién nacido se alimenta con dificultad por mala técnica de acople. No es alérgica a betalactámicos.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más apropiada?

- A. Suspender lactancia de ambas mamas por una semana
- B. Antibiótico antiestafilocócico y vaciamiento efectivo de la mama *
- C. Incisión y drenaje de rutina aunque no haya absceso
- D. Cabergolina para inhibir lactancia

Explicación: La mastitis puerperal suele relacionarse con estasis y *Staphylococcus aureus*. Debe tratarse con antibiótico adecuado y corrección del acople con continuación de vaciamiento; el drenaje se reserva para absceso documentado.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cáncer de Mama

Subtema: Nódulo mamario sospechoso

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 48 años detecta nódulo duro de 2 cm, fijo, en cuadrante superoexterno. Mastografía BI-RADS 5 y ultrasonido con lesión irregular espiculada; no hay adenopatía palpable. Niega secreción por pezón.

Pregunta: ¿Qué procedimiento establece el diagnóstico y permite planear tratamiento?

A. Punción aspiración simple y observación si sale líquido

B. Biopsia con aguja de corte guiada por imagen *

C. Mastectomía radical sin histología previa

D. Resonancia mamaria como único estudio definitivo

Explicación: Una lesión BI-RADS 5 requiere confirmación histopatológica antes de decidir cirugía sistémica o neoadyuvancia. La biopsia con aguja de corte permite tipificación, receptores y HER2 con menor morbilidad que cirugía diagnóstica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Infecciosa Cervical

Subtema: Enfermedad pélvica inflamatoria

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 22 años con dolor hipogástrico bilateral, dispareunia, flujo mucopurulento, fiebre de 38.1 C y dolor a la movilización cervical. Prueba de embarazo negativa; no hay masa anexial. Refiere nueva pareja y uso irregular de condón.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo empírico ambulatorio más apropiado?

- A. Fluconazol monodosis y abstinencia de 24 horas
- B. Ceftriaxona más doxiciclina y metronidazol con tratamiento de parejas *
- C. Amoxicilina aislada por diez días
- D. Esperar cultivo endocervical antes de iniciar antibiótico

Explicación: El dolor uterino o anexial con dolor cervical y riesgo sexual justifica tratamiento empírico de EPI para evitar secuelas. Debe cubrir gonococo, clamidia y anaerobios, además de tratar parejas y recomendar abstinencia hasta concluir tratamiento.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Infecciosa Cervical

Subtema: Candidosis vulvovaginal complicada

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 31 años con diabetes mal controlada presenta prurito intenso, eritema vulvar y flujo grumoso; pH vaginal 4.2 y microscopia con levaduras gemantes. Ha tenido cuatro episodios confirmados en ocho meses.

Pregunta: ¿Qué enfoque es más adecuado para esta recurrencia complicada?

- A. Metronidazol vaginal por cinco días
- B. Esquema de inducción azólica prolongada y terapia de mantenimiento *
- C. Penicilina benzatínica intramuscular
- D. Doxiciclina y tratamiento simultáneo de pareja asintomática

Explicación: La diabetes y recurrencias convierten el cuadro en candidosis complicada. Se requiere inducción más prolongada con azol y, cuando es recurrente, mantenimiento; el pH ácido y levaduras apoyan el diagnóstico, no vaginosis o cervicitis bacteriana.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-609-19, Diagnóstico y tratamiento de candidosis vulvovaginal en mujeres mayores a 12 años de edad. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control Prenatal

Subtema: Incompatibilidad Rh

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 26 años, grupo O Rh negativo, 28 semanas, Coombs indirecto negativo. Su pareja es Rh positivo y no ha presentado sangrado, procedimientos invasivos ni trauma. Embarazo previo terminó en aborto de ocho semanas sin profilaxis documentada.

Pregunta: ¿Qué intervención preventiva corresponde hoy?

- A. Inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas *
- B. Prueba de Kleihauer-Betke mensual sin inmunoglobulina
- C. Transfusión de eritrocitos Rh positivo
- D. Esperar al parto para decidir profilaxis

Explicación: La gestante no sensibilizada Rh negativa con posible feto Rh positivo debe recibir inmunoglobulina anti-D alrededor de las 28 semanas y de nuevo posparto si el neonato es Rh positivo, además de dosis tras eventos sensibilizantes.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control Prenatal

Subtema: Hiperemesis gravídica

Dificultad: alta

Caso clínico: Primigesta de 10 semanas con vómito persistente, pérdida de 6 por ciento del peso, cetonuria y potasio de 3.1 mEq/L. No tiene dolor abdominal, fiebre ni datos neurológicos; ultrasonido muestra gestación única viable.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad terapéutica inicial?

- A. Administrar tiamina antes de soluciones con glucosa y corregir volumen y electrolitos *
- B. Inducir interrupción del embarazo por cetonuria
- C. Dar hierro oral y manejar como náusea fisiológica
- D. Iniciar diurético para corregir edema gástrico

Explicación: La hiperemesis con deshidratación, hipokalemia y cetosis requiere hospitalización, líquidos y electrolitos. La tiamina debe administrarse antes de dextrosa para prevenir encefalopatía de Wernicke; después se añaden antieméticos seguros.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del Primer Trimestre

Subtema: Embarazo ectópico no roto

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 30 años, seis semanas desde FUM, presenta dolor pélvico leve y manchado. Beta-hCG de 2,800 mUI/mL, ultrasonido transvaginal sin saco intrauterino y masa tubárica de 2 cm sin actividad cardíaca; estable, sin líquido libre y función hepática normal.

Pregunta: ¿Qué tratamiento puede considerarse de primera línea si acepta seguimiento estricto?

A. Metotrexato intramuscular en dosis única con vigilancia de beta-hCG *

B. Lgrado uterino evacuador como único manejo

C. Misoprostol vaginal por sospecha de aborto incompleto

D. Salpingectomía obligatoria aunque no haya ruptura

Explicación: Cumple criterios para manejo médico de ectópico: estabilidad, masa pequeña, sin actividad embrionaria y posibilidad de seguimiento. El metotrexato requiere control seriado de beta-hCG, evitar folatos, alcohol y relaciones hasta resolución.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del Primer Trimestre

Subtema: Enfermedad trofoblástica gestacional

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 22 años con amenorrea de 12 semanas, hiperemesis desproporcionada, útero mayor a edad gestacional y beta-hCG muy elevada. Ultrasonido muestra patrón vesicular intrauterino sin embrión.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial indicado?

- A. Aspiración uterina por vacío con estudio histopatológico *
- B. Misoprostol ambulatorio sin seguimiento de hCG
- C. Quimioterapia inmediata antes de evacuar útero
- D. Histeroscopia diagnóstica para resección de vellosidades

Explicación: La mola hidatidiforme se evacua mediante aspiración uterina por vacío, con cuantificación de beta-hCG basal y seguimiento posterior. El misoprostol puede aumentar sangrado y no permite el mismo control; la quimioterapia se reserva para neoplasia persistente.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del Segundo Trimestre

Subtema: Placenta previa

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 32 semanas llega por sangrado rojo brillante indoloro, sin contracciones ni sensibilidad uterina. Ultrasonido previo describió placenta que cubre el orificio cervical interno. Feto reactivo, madre estable.

Pregunta: ¿Qué maniobra debe evitarse antes de definir la vía de nacimiento?

A. Especuloscopia cuidadosa

B. Tacto vaginal digital *

C. Ultrasonido transabdominal y transvaginal

D. Vigilancia fetal externa

Explicación: En sangrado con sospecha de placenta previa está contraindicado el tacto vaginal digital porque puede desencadenar hemorragia masiva. El ultrasonido transvaginal es seguro y confirma relación placentaria con el orificio cervical.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del Segundo Trimestre

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 35 semanas con hipertensión crónica presenta dolor abdominal súbito, útero hipertónico y sangrado oscuro escaso. Monitoreo fetal con desaceleraciones tardías repetidas. No hay antecedente de cesárea.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Tocolisis y vigilancia ambulatoria
- B. Terminar embarazo de forma expedita tras reanimación materna *
- C. Realizar tacto vaginal repetido para cuantificar sangrado
- D. Esperar maduración pulmonar 48 horas sin vigilancia intensiva

Explicación: El dolor, hipertonía, sangrado oscuro y compromiso fetal sugieren DPPNI. Con feto no tranquilizador se requiere estabilización materna, acceso venoso, hemoderivados según necesidad y terminación expedita, sin retraso por maduración pulmonar.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Preeclampsia con datos de severidad

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 31 semanas con cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. PA repetida 166/112 mmHg, plaquetas 95,000, creatinina 1.3 mg/dL y proteinuria de 2+. Feto con restricción de crecimiento y Doppler umbilical alterado.

Pregunta: ¿Qué medida inmediata reduce el riesgo de eclampsia?

- A. Sulfato de magnesio con vigilancia de toxicidad *
- B. Furosemida profiláctica para eliminar edema
- C. Aspirina a dosis baja como tratamiento agudo
- D. Nifedipino sublingual sin monitorización

Explicación: La preeclampsia con hipertensión grave y disfunción orgánica requiere estabilización hospitalaria. El sulfato de magnesio previene convulsiones; además se controla PA con antihipertensivo de acción rápida y se planifica terminación según estabilidad materno fetal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo: Estados Hipertensivos

Subtema: Síndrome HELLP

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 34 semanas con náusea, dolor en hipocondrio derecho, PA 150/96 mmHg, plaquetas 72,000, AST 210 U/L, DHL elevada y esquistocitos en frotis. No tiene fiebre ni diarrea sanguinolenta.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta definitiva?

- A. Corticoide oral y seguimiento semanal hasta término
- B. Terminación del embarazo después de estabilización materna *
- C. Transfusión plaquetaria exclusiva y alta
- D. Anticoagulación por anemia hemolítica

Explicación: Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia integran HELLP, una forma grave de enfermedad hipertensiva. Tras estabilizar, administrar sulfato de magnesio y corregir hemostasia cuando corresponda, la resolución definitiva es la terminación del embarazo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo

Subtema: Diabetes mellitus gestacional

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 29 semanas con glucosa en ayuno repetida de 108 mg/dL pese a dos semanas de plan nutricional individualizado y ejercicio seguro. Autocontroles posprandiales se mantienen dentro de meta; feto sin macrosomía.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente escalón terapéutico?

- A. Añadir insulina basal individualizada *
- B. Suspender controles porque los posprandiales son normales
- C. Iniciar estatina por riesgo cardiovascular
- D. Administrar metformina sin reevaluar glucosa

Explicación: El ayuno persistentemente fuera de meta pese a medidas no farmacológicas requiere insulinoterapia, ajustada al patrón glucémico. La insulina es el tratamiento farmacológico de referencia durante el embarazo y exige educación sobre hipoglucemia y monitorización.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del Embarazo

Subtema: Colestasis intrahepática del embarazo

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 34 semanas refiere prurito palmoplantar nocturno sin exantema. Bilirrubina normal, transaminasas discretamente elevadas y ácidos biliares totales de 58 micromol/L. Feto reactivo, sin hipertensión ni hemólisis.

Pregunta: ¿Qué fármaco mejora el prurito y los parámetros bioquímicos?

A. Ácido ursodesoxicólico *

B. Metotrexato semanal

C. Prednisona en dosis alta como único manejo

D. Vitamina K como tratamiento etiológico único

Explicación: La colestasis intrahepática se manifiesta con prurito sin lesiones y ácidos biliares elevados. El ácido ursodesoxicólico mejora síntomas y pruebas hepáticas; se agrega vigilancia fetal y se programa nacimiento según concentración de ácidos biliares y evolución.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Trabajo de Parto

Subtema: Fase activa y partograma

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de bajo riesgo, 39 semanas, 6 cm de dilatación, membranas íntegras y dinámica de tres contracciones de 45 segundos en 10 minutos. Tras cuatro horas la dilatación es 7 cm, trazado fetal categoría I.

Pregunta: ¿Cuál es la mejor conducta inicial?

- A. Diagnosticar detención y realizar cesárea inmediata
- B. Amniotomía y reevaluación de actividad uterina antes de concluir fracaso *
- C. Administrar tocolítico para prolongar fase activa
- D. Permitir pujo dirigido aunque no esté completa

Explicación: En fase activa, el progreso debe valorarse junto con actividad uterina y bienestar fetal. Sin datos de compromiso, se puede optimizar con amniotomía y, si hay dinámica inadecuada, oxitocina; la cesárea por detención exige criterios de tiempo y contracciones adecuados.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-052-19, Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología de Trabajo de Parto

Subtema: Distocia de hombros

Dificultad: alta

Caso clínico: Tras salida de la cabeza en parto vaginal de feto macrosómico, hay retracción contra el periné y no progresa con tracción suave. El equipo ya solicitó ayuda y suspendió presión fúndica.

Pregunta: ¿Qué maniobra debe realizarse primero?

A. Maniobra de McRoberts con presión suprapúbica *

B. Tracción cefálica sostenida y vigorosa

C. Versión interna podálica de rutina

D. Fórceps de Kielland sobre la cabeza ya exteriorizada

Explicación: La distocia de hombros exige acciones secuenciales y evitar tracción excesiva. McRoberts y presión suprapúbica son la primera maniobra porque aumentan el diámetro funcional pélvico y desimpactan el hombro anterior; la presión fúndica está contraindicada.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-052-19, Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología de Trabajo de Parto

Subtema: Embarazo gemelar

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 37 semanas con gemelos dicoriales diamnióticos. Gemelo A cefálico estimado en 2,650 g; gemelo B transverso estimado en 2,500 g. Sin placenta previa, preeclampsia ni cirugía uterina previa.

Pregunta: ¿Qué vía de nacimiento puede considerarse en un equipo con experiencia?

- A. Cesárea obligatoria porque el segundo gemelo no es cefálico
- B. Parto vaginal planificado con posibilidad de versión o extracción del segundo gemelo *
- C. Inducción fuera de hospital sin vigilancia fetal
- D. Parto vaginal solo si ambos pesan menos de 1,500 g

Explicación: Con primer gemelo cefálico, edad gestacional adecuada y equipo capacitado, el parto vaginal es una alternativa. El segundo gemelo puede requerir versión externa, interna o extracción podálica según presentación y estado fetal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-052-19, Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Parto Prematuro y Patología Coriónica

Subtema: Ruptura prematura de membranas pretérmino

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 30 semanas refiere salida continua de líquido claro. Especuloscopia confirma líquido en fondo de saco y prueba de cristalización positiva. No hay fiebre, dolor uterino, taquicardia fetal ni trabajo de parto; líquido amniótico disminuido.

Pregunta: ¿Qué intervención mejora la latencia y reduce morbilidad neonatal?

- A. Antibióticos de latencia y corticoide antenatal *
- B. Inducción inmediata sin intentar manejo expectante
- C. Tocolisis prolongada hasta las 37 semanas
- D. Antibiótico vaginal aislado sin corticoide

Explicación: En RPM pretérmino sin infección ni compromiso fetal, el manejo expectante hospitalario incluye corticoide y esquema antibiótico de latencia, que prolonga el embarazo y reduce infección neonatal. Se vigilan signos de corioamnionitis y bienestar fetal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Parto Prematuro y Patología Coriónica

Subtema: Corioamnionitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de 33 semanas con RPM de 30 horas, fiebre de 39 C, taquicardia materna de 118, fetal de 175 y dolor uterino. El líquido es maloliente. No hay otra fuente infecciosa aparente.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta indicada?

A. Antibióticos de amplio espectro y terminación del embarazo *

B. Tocolisis y corticoide por 48 horas antes de antibiótico

C. Vigilancia ambulatoria con antipirético

D. Cerclaje de rescate para prolongar gestación

Explicación: La fiebre intraparto con taquicardia fetal, sensibilidad uterina y líquido fétido indica infección intraamniótica. Requiere antibióticos intravenosos de amplio espectro y terminación del embarazo sin demorar por edad gestacional; la vía depende de indicación obstétrica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-272-18, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Puerperal

Subtema: Hemorragia posparto por atonía

Dificultad: alta

Caso clínico: Tras parto vaginal de gemelar, una mujer presenta sangrado abundante, útero blando por encima de ombligo y PA 92/56 mmHg. Se descartan desgarros visibles y placenta se reporta íntegra. Ya se realiza masaje bimanual y se asegura acceso venoso.

Pregunta: ¿Cuál es el uterotónico de primera línea?

A. Oxitocina intravenosa en infusión *

B. Sulfato de magnesio intravenoso

C. Terbutalina subcutánea

D. Nifedipino oral de liberación inmediata

Explicación: El útero blando tras sobre distensión corresponde a atonía, la causa más frecuente de hemorragia posparto. Junto con masaje y reanimación, oxitocina es el uterotónico inicial; después se escalan uterotónicos, balón y cirugía según respuesta.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Puerperal

Subtema: Choque hemorrágico obstétrico

Dificultad: alta

Caso clínico: Puérpera con sangrado activo por laceración cervical llega confusa, piel fría, pulso 132, PA 74/40 y diuresis escasa. La estimación visual de pérdida ha sido difícil y se dispone de protocolo de transfusión masiva.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad simultánea con control quirúrgico de la fuente?

- A. Reanimación hemostática con hemoderivados balanceados y calentamiento *
- B. Cristaloideos ilimitados hasta normalizar hemoglobina
- C. Hierro intravenoso antes de transfundir
- D. Esperar resultados de coagulación para iniciar reanimación

Explicación: El choque hemorrágico exige control inmediato de fuente y reanimación hemostática temprana. La transfusión balanceada, calcio, calentamiento y corrección de fibrinógeno reducen la coagulopatía de la tríada letal; los cristaloideos excesivos la empeoran.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Puerperal

Subtema: Sepsis puerperal

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer cuatro días después de cesárea presenta fiebre de 39 C, dolor uterino, loquios fétidos, FC 124 y lactato 3.8 mmol/L. La herida está limpia, PA 100/62 y ultrasonido sin restos evidentes.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención que no debe retrasarse?

- A. Tomar cultivos y administrar antibióticos intravenosos de amplio espectro en la primera hora *
- B. Esperar cultivo endometrial definitivo antes de antimicrobianos
- C. Dar solo antipirético y reevaluar en 24 horas
- D. Indicar legrado uterino sin antibióticos

Explicación: El cuadro corresponde a sepsis puerperal probable. Los cultivos se toman sin retrasar antibióticos de amplio espectro, reanimación y búsqueda de foco; posteriormente se ajusta tratamiento y se controla fuente si hay colección o tejido retenido.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-272-18, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna. Vigente.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología Ginecológica

Subtema: Bartholinitis en mujer mayor

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 47 años con masa unilateral dolorosa de 3 cm en glándula de Bartholin, de reciente aparición. No tiene fiebre, pero la lesión es firme y persiste tras antibiótico indicado previamente.

Pregunta: ¿Qué medida es obligada por su edad y hallazgo persistente?

A. Biopsia o escisión para descartar malignidad *

B. Drenaje simple con aguja y alta definitiva

C. Observación por seis meses sin revisión

D. Anticonceptivo combinado para reducir tamaño

Explicación: En mujeres mayores de 40 años una masa nueva de Bartholin requiere biopsia o escisión para excluir carcinoma, incluso si simula quiste. El drenaje simple tiene alta recurrencia y no aporta diagnóstico histológico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología Mamaria Benigna

Subtema: Papiloma intraductal

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 43 años refiere secreción unilateral espontánea, serohemática, por un solo conducto. No palpa masa; mastografía es negativa y ultrasonido identifica lesión intraductal retroareolar de 7 mm.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente procedimiento más útil?

- A. Resección o biopsia dirigida del conducto lesionado *
- B. Tranquilizar porque toda secreción sanguinolenta es fisiológica
- C. Dar antibiótico empírico por mastitis subclínica
- D. Medir prolactina como único estudio

Explicación: La secreción unilateral espontánea sanguinolenta de un solo conducto es patológica y sugiere papiloma intraductal o malignidad. La biopsia o escisión dirigida permite diagnóstico y tratamiento; prolactina explica secreción bilateral lechosa, no este patrón.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control Prenatal

Subtema: Hipotiroidismo en embarazo

Dificultad: alta

Caso clínico: Gestante de nueve semanas con tiroiditis de Hashimoto previa toma levotiroxina. TSH actual 5.1 mUI/L y T4 libre baja normal; refiere adherencia completa. No toma hierro al mismo tiempo.

Pregunta: ¿Qué ajuste es apropiado?

A. Aumentar levotiroxina y controlar TSH estrechamente *

B. Suspender levotiroxina hasta el segundo trimestre

C. Iniciar metimazol por TSH alta

D. Mantener dosis porque la TSH se eleva fisiológicamente

Explicación: Durante gestación aumentan los requerimientos de levotiroxina y se utilizan metas de TSH por trimestre. Una TSH elevada en hipotiroidismo tratado exige incremento de dosis y control cada cuatro a seis semanas para proteger desarrollo fetal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología de Trabajo de Parto

Subtema: Cesárea previa y prueba de trabajo de parto

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 30 años con una cesárea transversa baja por presentación pélvica, actualmente 39 semanas, feto cefálico único de peso estimado 3,200 g. No tiene cicatriz corporal, placenta previa ni antecedente de ruptura uterina y desea parto vaginal.

Pregunta: ¿Qué consejería es correcta?

- A. Puede ofrecerse prueba de trabajo de parto con vigilancia y capacidad de cesárea urgente *
- B. Está contraindicada toda labor por antecedente de una cesárea
- C. Debe inducirse con misoprostol a dosis altas en domicilio
- D. La ruptura uterina no requiere explicación porque es excepcional

Explicación: Con una cicatriz transversa baja y sin contraindicaciones, puede ofrecerse parto vaginal después de cesárea en unidad capaz de realizar intervención urgente. Se explica riesgo de ruptura uterina, éxito probable y alternativas; la inducción se individualiza.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-052-19, Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo. Vigente.

Especialidad: Pediatría

Tema: Recién Nacido Sano

Subtema: Tamiz auditivo neonatal

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término, sin malformaciones, egresa a las 36 horas con exploración normal. La madre pregunta si debe esperar a que el bebé hable para evaluar audición; no hay antecedente familiar de sordera ni estancia en UCIN.

Pregunta: ¿Qué recomendación corresponde al programa de detección oportuna?

- A. Realizar tamiz auditivo neonatal antes del primer mes de vida *
- B. Solicitar potenciales evocados solo si no dice palabras a los dos años
- C. Esperar otitis media recurrente para tamizar
- D. Hacer audiometría tonal al egreso como única prueba

Explicación: El tamiz auditivo debe completarse idealmente antes de un mes, aun en recién nacidos sin factores de riesgo. La detección temprana permite confirmación y acceso a intervención dentro de periodos críticos del desarrollo del lenguaje.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Recién Nacido Sano

Subtema: Parálisis braquial obstétrica

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido macrosómico tras distocia de hombros mantiene brazo derecho en aducción, rotación interna, codo extendido y antebrazo pronado. El reflejo de Moro está ausente de ese lado, pero la prensión palmar es conservada.

Pregunta: ¿Qué raíz o tronco está principalmente comprometido?

A. C5-C6, patrón de Erb-Duchenne *

B. C8-T1, patrón de Klumpke aislado

C. Nervio radial distal exclusivamente

D. Plexo lumbosacro bilateral

Explicación: La postura en propina con prensión preservada y lesión tras distocia de hombros corresponde a parálisis de Erb por afectación C5-C6. Debe iniciarse fisioterapia y vigilar recuperación, evitando inmovilización prolongada.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Reanimación Neonatal

Subtema: Ventilación a presión positiva

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 39 semanas nace flácido, apneico y con FC de 70 por minuto tras secado, posicionamiento y estimulación. Líquido amniótico claro.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inmediata más importante?

- A. Iniciar ventilación a presión positiva eficaz *
- B. Administrar compresiones torácicas de inmediato
- C. Intubar para aspiración traqueal rutinaria
- D. Dar adrenalina endotraqueal antes de ventilar

Explicación: En reanimación neonatal, apnea o FC menor de 100 requiere ventilación a presión positiva. La mayoría de bradicardias responde a ventilación efectiva; compresiones se indican si FC persiste menor de 60 tras 30 segundos de ventilación adecuada.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-632-13, Diagnóstico y tratamiento de la asfixia neonatal. Vigente.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Infecciosa

Subtema: Sepsis neonatal temprana

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacida de 35 semanas, madre con corioamnionitis, desarrolla a las dos horas letargo, quejido, mala perfusión y temperatura de 35.8 C. Se toman hemocultivos y biometría, sin retrasar atención; no hay defecto cardíaco conocido.

Pregunta: ¿Cuál es el esquema empírico inicial más indicado?

A. Ampicilina más gentamicina intravenosas *

B. Vancomicina más fluconazol desde el nacimiento

C. Ceftriaxona monoterapia

D. Aciclovir sin antibióticos

Explicación: La sepsis neonatal temprana asociada a infección intraamniótica requiere antibióticos tras obtener cultivos. Ampicilina más gentamicina cubre *Streptococcus agalactiae*, *Listeria* y bacilos gramnegativos; se ajusta al resultado microbiológico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Infecciosa

Subtema: Enterocolitis necrosante

Dificultad: alta

Caso clínico: Prematuro de 28 semanas, día 12 de vida, con distensión abdominal, residuo bilioso, sangre en heces, apnea y acidosis metabólica. Radiografía muestra neumatosis intestinal y gas portal.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial apropiada?

- A. Suspender vía enteral, descomprimir, antibióticos y soporte intensivo *
- B. Continuar leche materna en tomas pequeñas para madurar intestino
- C. Realizar colonoscopia diagnóstica
- D. Indicar loperamida por diarrea con sangre

Explicación: La neumatosis intestinal confirma enterocolitis necrosante. El tratamiento inicial comprende ayuno, sonda para descompresión, antibióticos con cobertura entérica, líquidos y vigilancia quirúrgica; neumoperitoneo o deterioro refractario sugieren cirugía.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Enfermedad de membrana hialina

Dificultad: alta

Caso clínico: Prematuro de 29 semanas presenta taquipnea, retracciones, quejido y requerimiento creciente de oxígeno a los 20 minutos de vida. Radiografía: volumen pulmonar bajo y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo.

Pregunta: ¿Qué estrategia respiratoria inicial es preferible si respira espontáneamente?

A. CPAP nasal precoz y surfactante selectivo si hay falla *

B. Oxígeno libre a alto flujo sin presión positiva

C. Intubación y ventilación invasiva obligatoria para todos

D. Diurético intravenoso por edema alveolar

Explicación: El síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante se maneja inicialmente con CPAP nasal en el prematuro con respiración espontánea; se administra surfactante si aumenta requerimiento de oxígeno o hay falla, minimizando ventilación invasiva.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Pediátrico

Subtema: Síndrome de aspiración de meconio

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 41 semanas con líquido meconial espeso nace vigoroso. A las dos horas desarrolla taquipnea, tórax hiperinsuflado y radiografía con infiltrados parcheados alternando con áreas de hiperclaridad.

Pregunta: ¿Qué conducta fue correcta en sala de partos?

- A. No realizar aspiración traqueal rutinaria en un recién nacido vigoroso *
- B. Intubar y aspirar tráquea a todo recién nacido con meconio
- C. Iniciar antibióticos sin evaluación respiratoria
- D. Administrar surfactante profiláctico a todos antes de síntomas

Explicación: En recién nacido vigoroso con líquido meconial no se indica aspiración traqueal rutinaria. El aspirado de meconio se trata según dificultad respiratoria con oxígeno titulado, soporte ventilatorio y vigilancia de hipertensión pulmonar.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-632-13, Diagnóstico y tratamiento de la asfixia neonatal. Vigente.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Malformativa

Subtema: Hernia diafragmática congénita

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido con dificultad respiratoria extrema desde el nacimiento, abdomen excavado y ruidos intestinales en hemitórax izquierdo. Se sospecha hernia diafragmática; la saturación preductal es 78 por ciento.

Pregunta: ¿Cuál es la primera medida ventilatoria?

A. Intubación endotraqueal y sonda orogástrica a descompresión *

B. Ventilación con bolsa y mascarilla vigorosa

C. CPAP nasal con presión alta

D. Alimentación enteral temprana para movilizar intestino

Explicación: La ventilación con bolsa y mascarilla insufla asas intratorácicas y empeora compresión pulmonar. Se requiere intubación con ventilación protectora y descompresión gástrica; la reparación se posterga hasta estabilización cardiorrespiratoria.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Malformativa

Subtema: Atresia esofágica

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido presenta sialorrea abundante, tos y cianosis con el primer intento de alimentación. Una sonda orogástrica no progresa y se enrolla en mediastino superior; radiografía muestra gas abdominal.

Pregunta: ¿Qué variante anatómica es más probable?

A. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal *

B. Atresia esofágica sin fístula distal

C. Fístula traqueoesofágica aislada sin atresia

D. Estenosis pilórica hipertrófica

Explicación: La sonda detenida confirma atresia y el gas abdominal implica comunicación distal con vía aérea, la variante más frecuente. Debe suspenderse alimentación, aspirar bolsa proximal y valorar anomalías asociadas antes de reparación quirúrgica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Congénita Infecciosa

Subtema: Sífilis congénita

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de madre con sífilis tratada de manera incompleta presenta rinitis serosanguinolenta, hepatomegalia, anemia y lesiones maculopapulares palmo plantares. VDRL neonatal es mayor que el materno en cuatro diluciones.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento indicado?

A. Penicilina G cristalina intravenosa por 10 días *

B. Azitromicina oral dosis única

C. Ceftriaxona intramuscular semanal

D. Observación porque los anticuerpos pueden ser maternos

Explicación: La clínica compatible y título no treponémico neonatal cuatro veces mayor sugieren sífilis congénita confirmada. El tratamiento es penicilina G cristalina intravenosa por 10 días, con estudio de LCR, huesos y seguimiento serológico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Estenosis Hipertrófica del Píloro

Subtema: Alcalosis metabólica hipoclorémica

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de cinco semanas vomita en proyectil después de cada toma, sin bilis, con hambre inmediata y pérdida ponderal. Palpación abdominal detecta oliva epigástrica; cloro 87 mEq/L, potasio 3.0 mEq/L y bicarbonato 34 mEq/L.

Pregunta: ¿Qué paso debe preceder a la piloromiotomía?

- A. Corregir deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas *
- B. Operar de urgencia sin líquidos para evitar aspiración
- C. Iniciar eritromicina y alta
- D. Administrar bicarbonato por alcalosis

Explicación: La estenosis pilórica se confirma por ultrasonido, pero la cirugía se difiere hasta reponer volumen, cloro y potasio. La alcalosis metabólica hipoclorémica refleja pérdidas gástricas y aumenta riesgo anestésico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Ictericia Neonatal

Subtema: Ictericia por isoinmunización Rh

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de 30 horas, grupo A Rh positivo, hijo de madre O Rh negativo sensibilizada, tiene ictericia hasta muslos, hemoglobina 11 g/dL, reticulocitos 10 por ciento y Coombs directo positivo. Bilirrubina asciende rápidamente.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial más efectiva para reducir neurotoxicidad?

- A. Fototerapia intensiva inmediata *
- B. Esperar ictericia fisiológica hasta las 72 horas
- C. Suspender alimentación y dar agua glucosada
- D. Iniciar quelación de bilirrubina

Explicación: La hemólisis inmune causa hiperbilirrubinemia temprana de rápido ascenso y anemia. La fototerapia intensiva reduce bilirrubina no conjugada; se vigilan umbrales para inmunoglobulina o exanguinotransfusión según nomograma y evolución.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-262-19, Diagnóstico y tratamiento de la ictericia neonatal. Vigente.

Especialidad: Pediatría

Tema: Tamiz Metabólico

Subtema: Hipotiroidismo congénito

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacida con tamiz de TSH muy elevada, confirmación de TSH 82 mUI/L y T4 libre baja. Tiene fontanela posterior amplia, macroglosia leve y estreñimiento, aunque se alimenta aceptablemente.

Pregunta: ¿Qué conducta evita discapacidad intelectual prevenible?

- A. Iniciar levotiroxina de inmediato sin esperar imagen tiroidea *
- B. Esperar gammagrama antes de tratamiento
- C. Dar yodo oral empírico por seis meses
- D. Repetir tamiz a los tres meses

Explicación: El hipotiroidismo congénito debe tratarse en cuanto se confirma, idealmente dentro de las primeras dos semanas. La imagen puede definir etiología, pero nunca debe retrasar levotiroxina, cuyo objetivo es normalizar T4 y TSH para preservar neurodesarrollo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Crecimiento y Desarrollo

Subtema: Maltrato infantil

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de ocho meses con irritabilidad y equimosis en pabellón auricular es llevado por cuidador con relato inconsistente de caída desde sofá. Radiografía de cráneo muestra lesión metafisaria clásica en tibia y examen de fondo de ojo revela hemorragias retinianas.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad médica y legal?

- A. Proteger al menor, tratar lesiones y activar protocolo de notificación multidisciplinaria *
- B. Confrontar al cuidador y dar alta si niega agresión
- C. Esperar una segunda lesión para confirmar patrón
- D. Limitar evaluación a radiografía de la extremidad dolorosa

Explicación: Las lesiones metafisarias, auriculares y hemorragias retinianas con historia discordante son altamente sugestivas de maltrato. Se debe asegurar protección, atención médica integral, documentación objetiva, estudio de lesiones ocultas y notificación conforme al marco institucional.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Crecimiento y Desarrollo

Subtema: Desnutrición aguda severa

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de 18 meses con edema bilateral de pies, perímetro braquial de 10.5 cm, apatía, hepatomegalia y diarrea. Glucosa capilar 48 mg/dL, temperatura 35.4 C y no hay choque manifiesto.

Pregunta: ¿Qué intervención inicial es prioritaria?

A. Corregir hipoglucemia e hipotermia con alimentación terapéutica cautelosa *

B. Iniciar dieta hipercalórica abundante de inmediato

C. Administrar diurético por edema

D. Dar hierro en dosis alta desde la primera hora

Explicación: El niño con desnutrición aguda severa puede morir por hipoglucemia, hipotermia e infección. Primero se estabiliza con glucosa, calentamiento, antibióticos según protocolo y alimentación inicial cautelosa; el hierro se introduce en fase de rehabilitación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Vacunación

Subtema: Anafilaxia posterior a vacuna

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de seis meses desarrolla urticaria generalizada, sibilancias, vómitos y letargo cinco minutos después de una vacuna. Presenta pulso débil y llenado capilar lento.

Pregunta: ¿Cuál es el medicamento de primera línea?

- A. Adrenalina intramuscular en muslo anterolateral *
- B. Difenhidramina oral como único tratamiento
- C. Hidrocortisona intravenosa antes de adrenalina
- D. Salbutamol aislado sin adrenalina

Explicación: La anafilaxia tiene compromiso cutáneo y respiratorio o circulatorio de inicio agudo. La adrenalina intramuscular es el tratamiento prioritario y no debe retrasarse por antihistamínicos o esteroides; se añade oxígeno, líquidos y observación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Gastrointestinal Pediátrica

Subtema: Invaginación intestinal

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de nueve meses con episodios de llanto inconsolable, flexión de piernas y vómito evoluciona a heces con moco y sangre. Entre crisis está somnoliento; ultrasonido muestra signo de diana sin datos de perforación.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo diagnóstico terapéutico de elección?

- A. Reducción con enema neumático o hidrostático guiado *
- B. Laparotomía inmediata en todos los casos
- C. Laxante osmótico y observación
- D. Colonoscopia electiva tras antibiótico

Explicación: La intususcepción estable sin peritonitis ni perforación se reduce mediante enema neumático o hidrostático bajo imagen, que además confirma diagnóstico. Cirugía se reserva para falla de reducción, choque, perforación o peritonitis.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Gastrointestinal Pediátrica

Subtema: Enfermedad de Hirschsprung

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido de término no expulsa meconio en las primeras 48 horas, tiene distensión progresiva y vómito bilioso. Tras estimulación rectal expulsa explosivamente heces y gas. Enema contrastado muestra zona de transición rectosigmoidea.

Pregunta: ¿Qué estudio confirma el diagnóstico?

- A. Biopsia rectal por succión sin células ganglionares *
- B. Cultivo de heces para descartar sepsis
- C. pHmetría esofágica
- D. Prueba de sudor

Explicación: La ausencia de meconio, distensión y transición sugieren aganglionosis. La confirmación se realiza con biopsia rectal que demuestra ausencia de células ganglionares e hipertrofia nerviosa; el tratamiento definitivo es quirúrgico tras estabilización.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Deshidratación grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de dos años con gastroenteritis tiene letargo, ojos hundidos, pliegue cutáneo que retorna muy lentamente, respiración profunda y pulsos débiles. No puede beber.

Pregunta: ¿Cuál es el plan de rehidratación indicado?

- A. Plan C con solución isotónica intravenosa y reevaluación frecuente *
- B. Plan A en domicilio con líquidos habituales
- C. Plan B oral de 75 mL/kg sin vigilancia
- D. Antidiarreico antimotilidad y ayuno

Explicación: Los signos de letargo, incapacidad para beber y mala perfusión indican deshidratación grave. El Plan C utiliza solución isotónica intravenosa con reevaluación clínica estrecha, y se inicia solución de rehidratación oral cuando pueda beber.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Diarrea en el Pediátrico

Subtema: Enfermedad celíaca

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de cuatro años con diarrea crónica, distensión, anemia ferropénica refractaria y peso bajo. Tiene IgA total normal y anticuerpos anti transglutaminasa IgA muy elevados. No ha iniciado dieta sin gluten.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada?

- A. Referir para confirmación según criterios y mantener gluten hasta completar estudio *
- B. Eliminar gluten inmediatamente y no realizar evaluación adicional
- C. Iniciar antibiótico por sobrecrecimiento bacteriano
- D. Solicitar prueba de sudor como único estudio

Explicación: Con serología altamente sugestiva, debe completarse algoritmo diagnóstico por especialista, manteniendo exposición a gluten hasta la confirmación para evitar falsos negativos. Posteriormente la dieta sin gluten es estricta y de por vida con seguimiento nutricional.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Enfermedades Parasitarias

Subtema: Giardiasis

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de cinco años que asiste a guardería presenta diarrea fétida, grasa, distensión y pérdida de peso después de excursión con agua de pozo. No hay fiebre ni sangre en heces.

Pregunta: ¿Qué tratamiento específico es apropiado tras confirmación parasitológica?

A. Tinidazol o metronidazol en esquema indicado *

B. Ceftriaxona intravenosa por siete días

C. Albendazol mensual por un año

D. Loperamida de mantenimiento

Explicación: La diarrea malabsortiva fétida sin invasión tras agua contaminada sugiere Giardia. Tras confirmación por antígeno o examen coproparasitoscópico se emplea tinidazol o metronidazol; además se revisan contactos y medidas de higiene.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Lactante y Preescolar

Subtema: Bronquiolitis

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de cuatro meses con primer episodio de sibilancias, rinorrea previa, taquipnea y retracciones leves. Saturación 93 por ciento al aire ambiente, come la mitad de sus tomas y no hay apnea.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo recomendado?

A. Soporte con hidratación, aspiración nasal y oxígeno solo si hipoxemia persistente *

B. Salbutamol programado y esteroide sistémico para todos

C. Antibiótico por riesgo de neumonía bacteriana

D. Radiografía y biometría en todo lactante estable

Explicación: La bronquiolitis típica se trata con medidas de soporte. Broncodilatadores, esteroides, antibióticos y estudios rutinarios no han demostrado beneficio en cuadros no complicados; se vigilan alimentación, trabajo respiratorio y saturación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Respiratoria del Lactante y Preescolar

Subtema: Laringotraqueítis viral

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de dos años con coriza de dos días despierta con tos perruna, estridor inspiratorio en reposo y retracciones moderadas. Está afebril, sin sialorrea y tolera líquidos.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado?

A. Dexametasona y adrenalina nebulizada por estridor en reposo *

B. Amoxicilina oral y alta inmediata

C. Exploración faríngea agresiva con abatelenguas

D. Intubación rutinaria sin tratamiento médico

Explicación: El estridor en reposo indica crup moderado. Dexametasona disminuye evolución y adrenalina nebulizada produce mejoría transitoria; se observa tras administrarla. La ausencia de sialorrea y toxicidad hace menos probable epiglotitis.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Neumonías

Subtema: Neumonía adquirida en comunidad

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de seis años con fiebre de 39 C, tos, taquipnea, dolor pleurítico y estertores focales. Saturación 96 por ciento, tolera vía oral y no tiene dificultad respiratoria grave. Radiografía no es necesaria para decidir manejo ambulatorio.

Pregunta: ¿Cuál es el antibiótico oral inicial de elección?

A. Amoxicilina a dosis alta *

B. Azitromicina para todo cuadro lobar

C. Ciprofloxacino como primera línea

D. Trimetoprim sulfametoxazol por cinco días

Explicación: En niña inmunizada con neumonía bacteriana no complicada, *Streptococcus pneumoniae* es el principal patógeno y amoxicilina a dosis alta es primera línea. Macrólido se reserva para sospecha de patógenos atípicos según edad y cuadro.

Fuente: Secretaría de Salud. SS-120-08, Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 3 meses a 18 años en el primer y segundo nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Pediatría

Tema: Asma en el Adulto y Pediátrico

Subtema: Exacerbación asmática grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 14 años con asma tiene disnea, habla palabras aisladas, uso de músculos accesorios, sibilancias escasas y saturación 88 por ciento. Pico flujo es 35 por ciento del predicho.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inicial correcta?

- A. Oxígeno, beta2 agonista inhalado repetido, ipratropio y corticoide sistémico *
- B. Antibiótico y expectorante como único tratamiento
- C. Sedación para disminuir ansiedad
- D. Suspender broncodilatador por sibilancias escasas

Explicación: La hipoxemia, habla entrecortada y flujo menor de 50 por ciento indican exacerbación grave. Se administran oxígeno, salbutamol repetido, ipratropio y corticoide sistémico, con reevaluación temprana y consideración de sulfato de magnesio.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: IRAS y Convulsiones

Subtema: Faringoamigdalitis estreptocócica

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de ocho años con fiebre, odinofagia intensa, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos. Prueba rápida para estreptococo es positiva.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de tratar con penicilina o amoxicilina?

- A. Prevenir fiebre reumática aguda y acortar contagio *
- B. Evitar toda otitis media futura
- C. Erradicar portación de virus Epstein Barr
- D. Prevenir bronquiolitis

Explicación: La confirmación de *Streptococcus pyogenes* justifica antibiótico. Penicilina o amoxicilina erradica el germen, reduce transmisión y previene fiebre reumática aguda cuando se administra oportunamente; no se indica en faringitis viral.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Enfermedades Exantemáticas

Subtema: Enfermedad de Kawasaki

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de tres años con fiebre de seis días, conjuntivitis bilateral no purulenta, labios fisurados, lengua en fresa, edema de manos y exantema polimorfo. Ecocardiograma inicial no muestra aneurismas.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento que debe iniciarse sin esperar cambios coronarios?

A. Inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico *

B. Penicilina benzatínica y aislamiento respiratorio

C. Aciclovir intravenoso

D. Corticoide inhalado como monoterapia

Explicación: La fiebre prolongada con criterios mucocutáneos sugiere Kawasaki. La inmunoglobulina intravenosa temprana reduce aneurismas coronarios y se acompaña de ácido acetilsalicílico; un ecocardiograma inicialmente normal no excluye la enfermedad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Urgencias Pediátricas

Subtema: Intoxicación por paracetamol

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 13 años ingirió intencionalmente 180 mg/kg de paracetamol hace cinco horas. Está asintomático, transaminasas normales y no ha vomitado.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso que permite decidir antídoto con seguridad?

- A. Tomar concentración sérica a las cuatro o más horas y usar nomograma de Rumack Matthew *
- B. Esperar ictericia antes de medir niveles
- C. Dar carbón activado a las 24 horas como única medida
- D. Inducir vómito en domicilio

Explicación: Una ingesta potencialmente tóxica requiere concentración plasmática tomada al menos cuatro horas después y aplicación del nomograma para ingesta aguda única. Si el nivel cruza línea de tratamiento, se inicia N acetilcisteína; no se espera daño hepático.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Urgencias Pediátricas

Subtema: Ingesta de cáusticos

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de dos años ingiere destapacaños alcalino y presenta sialorrea, disfagia y dolor oral. Está hemodinámicamente estable, sin estridor.

Pregunta: ¿Qué acción debe evitarse?

- A. Inducir vómito o neutralizar con ácido *
- B. Mantener ayuno y valorar vía aérea
- C. Solicitar evaluación endoscópica oportuna según síntomas
- D. Administrar analgesia y líquidos intravenosos

Explicación: En ingesta cáustica no se induce vómito ni se intenta neutralización porque se reexpone el esófago o genera reacción térmica. Se prioriza vía aérea, ayuno y endoscopia en ventana adecuada para definir extensión de la lesión.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Torsión testicular

Dificultad: alta

Caso clínico: Adolescente de 15 años con dolor escrotal izquierdo súbito de dos horas, náusea, testículo elevado y reflejo cremastérico ausente. Doppler no está disponible de inmediato.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta correcta?

A. Exploración quirúrgica urgente sin retrasar por ultrasonido *

B. Antibiótico y elevación escrotal por probable epididimitis

C. Observar seis horas hasta que aparezca edema

D. Reducir manualmente y dar alta sin fijación contralateral

Explicación: La presentación clásica de torsión testicular es una urgencia tiempo dependiente. Si la sospecha clínica es alta, la exploración no debe retrasarse por imagen; se detorsiona, evalúa viabilidad y realiza orquidopexia bilateral.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Uropedia

Subtema: Infección urinaria febril

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de siete meses con fiebre de 39 C sin foco tiene uroanálisis por cateterismo con piuria, nitritos positivos y urocultivo con E coli mayor a 100,000 UFC/mL. Está hidratado, tolera vía oral y no luce tóxico.

Pregunta: ¿Qué estudio de imagen es apropiado tras el primer episodio febril?

A. Ultrasonido renal y vesical *

B. Cistouretrografía miccional inmediata para todos

C. Tomografía con contraste de urgencia

D. Gammagrama renal diario durante antibiótico

Explicación: Tras una primera IVU febril se realiza ultrasonido renal y vesical para detectar anomalías estructurales. La cistouretrografía se reserva para ultrasonido anormal, recurrencias u otras circunstancias de riesgo, evitando estudios invasivos indiscriminados.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Cardiopedía

Subtema: Tetralogía de Fallot y crisis hipercianótica

Dificultad: alta

Caso clínico: Lactante de ocho meses con Tetralogía de Fallot llora intensamente y desarrolla cianosis profunda, taquipnea y soplo sistólico menos audible. Se calma parcialmente al flexionar piernas.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial durante la crisis?

- A. Colocar en posición genupectoral y administrar oxígeno *
- B. Administrar furosemida por sobrecarga pulmonar
- C. Ventilar con presión positiva alta de rutina
- D. Dar prostaglandina E1 como único manejo

Explicación: La crisis hipercianótica ocurre por aumento de cortocircuito derecho izquierdo. La posición genupectoral incrementa resistencia vascular sistémica y reduce shunt; se añade oxígeno, calma, líquidos y beta bloqueo según gravedad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Cardiología

Subtema: Transposición de grandes vasos

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido con cianosis intensa desde minutos de vida, saturación 65 por ciento que no mejora con oxígeno, precordio activo y radiografía con silueta estrecha. Ecocardiograma confirma transposición de grandes arterias con comunicación interauricular pequeña.

Pregunta: ¿Qué fármaco debe iniciarse mientras se organiza intervención?

- A. Prostaglandina E1 para mantener conducto arterioso permeable *
- B. Indometacina para cerrar el conducto
- C. Digoxina para convertir circulación en serie
- D. Furosemida para mejorar mezcla

Explicación: La transposición requiere mezcla entre circuitos paralelos. Prostaglandina E1 mantiene el conducto arterioso y mejora oxigenación mientras se valora septostomía auricular y corrección arterial; el cierre ductal empeoraría la cianosis.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Especialidades Pediátricas

Subtema: Púrpura de Henoch-Schönlein

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de siete años con púrpura palpable simétrica en piernas y glúteos, artralgia de tobillos y dolor abdominal cólico. Plaquetas 320,000, TP normal y tira de orina con hematuria microscópica.

Pregunta: ¿Qué vigilancia es indispensable durante el seguimiento?

A. Presión arterial y examen urinario seriados *

B. Conteo plaquetario diario como único control

C. Tomografía abdominal mensual

D. Prueba de tuberculina semanal

Explicación: La púrpura de IgA se reconoce por púrpura no trombocitopénica, dolor articular y gastrointestinal. La nefritis puede aparecer tardíamente, por lo que se vigilan presión arterial, hematuria y proteinuria para identificar compromiso renal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Especialidades Pediátricas

Subtema: Púrpura trombocitopénica inmune

Dificultad: alta

Caso clínico: Niña de cinco años, previamente sana, presenta petequias y equimosis una semana después de infección viral. Plaquetas 14,000, hemoglobina y leucocitos normales; no tiene sangrado mucoso ni hepatosplenomegalia.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A. Observación estrecha y educación sobre signos de sangrado *
- B. Aspirina a dosis baja para prevenir microtrombos
- C. Transfusión profiláctica de plaquetas cada 24 horas
- D. Esplenectomía urgente

Explicación: La PTI típica es trombocitopenia aislada posviral sin sangrado importante. En niños con plaquetas bajas pero sin hemorragia mucosa o de riesgo, se prefiere observación y restricciones prudentes; inmunoglobulina o esteroide se usan según sangrado y contexto.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Alteraciones Cromosómicas

Subtema: Síndrome de Down y cardiopatía

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido con hipotonía, pliegue palmar único y rasgos compatibles con trisomía 21 presenta taquipnea, diaforesis al comer y soplo holosistólico paraesternal bajo.

Pregunta: ¿Qué lesión cardíaca es especialmente frecuente y debe buscarse con ecocardiograma?

- A. Defecto de canal auriculoventricular *
- B. Coartación de aorta como lesión típica principal
- C. Transposición de grandes vasos aislada
- D. Atresia tricuspídea en todos los casos

Explicación: En síndrome de Down son frecuentes los defectos septales y el canal auriculoventricular completo. El ecocardiograma temprano permite identificar cardiopatía estructural y orientar manejo de insuficiencia cardíaca y reparación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Congénita Infecciosa

Subtema: Citomegalovirus congénito

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido pequeño para edad gestacional con petequias tipo muffin de arándano, microcefalia, hepatoesplenomegalia y calcificaciones periventriculares en neuroimagen. Madre tuvo síndrome mononucleósico leve durante gestación.

Pregunta: ¿Cuál es la prueba diagnóstica más útil en las primeras tres semanas?

- A. PCR de CMV en saliva u orina *
- B. IgG sérica aislada de la madre
- C. Cultivo de heces para toxoplasma
- D. Prueba de tuberculina neonatal

Explicación: La infección congénita por CMV se confirma detectando virus en saliva u orina dentro de las primeras tres semanas; después puede ser infección posnatal. La clínica y calcificaciones periventriculares orientan y obligan a evaluar audición y SNC.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología Neonatal Malformativa

Subtema: Atresia duodenal

Dificultad: alta

Caso clínico: Recién nacido con vómito bilioso desde la primera toma, distensión epigástrica leve y antecedente prenatal de polihidramnios. Radiografía simple muestra signo de doble burbuja sin gas distal.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial?

A. Descompresión nasogástrica, líquidos y valoración quirúrgica *

B. Alimentación fraccionada con fórmula hidrolizada

C. Enema de contraste terapéutico

D. Antibiótico oral y vigilancia domiciliaria

Explicación: La doble burbuja sin gas distal es típica de atresia duodenal. Los vómitos biliosos son obstrucción distal a la ampolla hasta demostrar lo contrario y requieren ayuno, descompresión, corrección hidroelectrolítica y reparación quirúrgica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Introducción a Cirugía y Cirugía Abdominal

Subtema: Abdomen agudo perforado

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 54 años con dolor epigástrico súbito que se generaliza, abdomen en tabla y ausencia de ruidos intestinales. Usa AINEs crónicamente; radiografía de tórax de pie muestra aire libre subdiafrágico. PA 96/60 tras líquidos iniciales.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Reanimación, antibióticos y cirugía urgente para control de fuente *
- B. Endoscopia diferida y alta con inhibidor de bomba
- C. Colonoscopia terapéutica de urgencia
- D. Observación hasta que desaparezca el neumoperitoneo

Explicación: El neumoperitoneo con peritonitis difusa indica perforación de víscera hueca, probablemente úlcera péptica. Requiere reanimación, sonda, antibióticos, inhibidor de bomba y control quirúrgico de fuente sin retraso.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Esofágica

Subtema: Acalasia

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 39 años con disfagia progresiva para sólidos y líquidos, regurgitación nocturna y pérdida de peso. Endoscopia sin tumor; esofagograma muestra pico de pájaro y manometría aperistalsis con relajación incompleta del EEI.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento definitivo más eficaz en paciente operable?

- A. Miotomía de Heller laparoscópica con procedimiento antirreflujo *
- B. Dilatación con balón como cura obligatoria única
- C. Inhibidor de bomba en monoterapia
- D. Esofagectomía inicial

Explicación: La manometría confirma acalasia. En paciente joven operable, la miotomía de Heller con funduplicatura parcial ofrece alivio duradero y controla reflujo; dilatación neumática es alternativa, no requiere esofagectomía inicial.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Gástrica

Subtema: Úlcera péptica con sangrado alto

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 66 años con melena, síncope y Hb 7.8 g/dL. Tras reanimación y PPI intravenoso, endoscopia muestra úlcera duodenal con vaso visible no sangrante.

Pregunta: ¿Qué manejo endoscópico es indicado?

A. Hemostasia endoscópica del vaso visible más PPI de alta dosis *

B. Alta porque no hay sangrado activo en ese momento

C. Cirugía inmediata sin intento endoscópico

D. Erradicación de H pylori como única intervención urgente

Explicación: Un vaso visible es estigma de alto riesgo de resangrado. Requiere terapia endoscópica hemostática combinada y PPI intravenoso de alta dosis; se evalúa H pylori después y se reserva intervención radiológica o cirugía para falla.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Gástrica

Subtema: Síndrome de Zollinger-Ellison

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 45 años con múltiples úlceras duodenales distales, diarrea crónica y úlcera recurrente pese a PPI. Gastrina en ayuno muy elevada y pH gástrico menor de 2.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente estudio confirmatorio cuando la gastrina no es diagnóstica por sí sola?

- A. Prueba de estimulación con secretina *
- B. Prueba de aliento para H pylori
- C. Manometría esofágica
- D. pHmetría ambulatoria

Explicación: Úlceras múltiples distales y diarrea sugieren gastrinoma. Si hay hipergastrinemia con ácido gástrico presente, la prueba de secretina confirma respuesta paradójica de gastrina; se continúa PPI y se localiza tumor posteriormente.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colecistitis aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 46 años con dolor en hipocondrio derecho de 18 horas, fiebre, leucocitosis y Murphy sonográfico positivo con cálculo impactado en cuello vesicular. No tiene ictericia ni dilatación de colédoco.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento definitivo durante este ingreso?

A. Colecistectomía laparoscópica temprana *

B. Antibióticos y diferir cirugía seis meses en todos

C. CPRE de rutina sin datos de coledocolitiasis

D. Colecistostomía percutánea en paciente de bajo riesgo

Explicación: La colecistitis litiásica no complicada en paciente apta se trata con colecistectomía laparoscópica temprana durante el mismo ingreso, más analgesia y antibióticos selectivos. La CPRE se reserva para sospecha de cálculos en colédoco.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-237-09, Colecistitis y colelitiasis en el primero y segundo nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Colangitis aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 72 años con fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, PA 82/48 y confusión. Ultrasonido muestra colédoco de 13 mm con lito distal. Recibe líquidos, vasopresor y antibióticos.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso que controla la causa?

A. Drenaje biliar urgente mediante CPRE *

B. Colectomía electiva sin descompresión

C. Solo antibióticos por 14 días

D. Resonancia magnética antes de toda intervención

Explicación: La pentada de Reynolds indica colangitis grave con choque. Además de reanimación y antibióticos, requiere descompresión biliar urgente, usualmente CPRE; cirugía o drenaje percutáneo son alternativas cuando no es posible.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-237-09, Colectitis y coleditis en el primero y segundo nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Biliar

Subtema: Íleo biliar

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 81 años con cólicos, vómitos biliosos y distensión. Tomografía muestra obstrucción de intestino delgado, neumobilia y cálculo de 3 cm impactado en íleon terminal.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico usual en paciente frágil?

- A. Enterolitotomía para resolver la obstrucción *
- B. Whipple urgente con reparación de fístula
- C. Antibióticos y dieta líquida
- D. Colectomía aislada sin extraer cálculo

Explicación: La tríada de Rigler confirma íleo biliar. En pacientes añosos el objetivo inicial es resolver la obstrucción mediante enterolitotomía; reparación de fístula y colectomía en un tiempo se seleccionan cuidadosamente por mayor morbilidad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-237-09, Colectitis y coledocitis en el primero y segundo nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis aguda biliar

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 50 años con dolor epigástrico irradiado a espalda, lipasa cinco veces normal y tomografía con inflamación peripancreática sin necrosis. Bilirrubina 1.0 mg/dL, no hay colangitis ni falla orgánica.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta respecto a vía biliar?

A. No realizar CPRE urgente; programar colecistectomía en el mismo ingreso al resolverse *

B. Hacer CPRE urgente a toda pancreatitis biliar

C. Indicar colecistectomía durante las primeras seis horas con dolor activo

D. Dar antibiótico profiláctico contra necrosis estéril

Explicación: Cumple criterios de pancreatitis aguda leve. Sin colangitis ni obstrucción persistente, CPRE urgente no aporta beneficio. Tras reanimación y alimentación temprana según tolerancia, la colecistectomía en el mismo ingreso previene recurrencia.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-239-09, Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Pancreática

Subtema: Pancreatitis necrosante infectada

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 58 años con pancreatitis grave mejora inicialmente, pero al día 18 desarrolla fiebre, leucocitosis y deterioro. Tomografía muestra necrosis encapsulada con burbujas de gas. Está estable con antibióticos dirigidos.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia intervencionista preferible?

A. Abordaje escalonado con drenaje percutáneo o endoscópico y necrosectomía diferida si falla *

B. Laparotomía abierta inmediata con necrosectomía extensa

C. Antibiótico profiláctico sin control de colección

D. CPRE rutinaria por gas intrapancreático

Explicación: El gas en necrosis encapsulada sugiere infección. Cuando es posible se retrasa intervención hasta que la colección madure y se usa enfoque escalonado, comenzando con drenaje mínimamente invasivo; la necrosectomía se reserva para persistencia de sepsis.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-239-09, Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Apendicitis

Subtema: Apendicitis complicada con absceso

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 32 años con siete días de dolor en fosa iliaca derecha, fiebre y masa dolorosa. Tomografía muestra absceso periapendicular de 5 cm bien delimitado, sin peritonitis difusa.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado?

- A. Antibióticos y drenaje percutáneo si es accesible *
- B. Apendicectomía abierta inmediata en todos los casos
- C. Alta con analgésico por masa localizada
- D. Colonoscopia urgente para drenar absceso

Explicación: Un absceso periapendicular contenido sin peritonitis generalizada se trata inicialmente con antibióticos y drenaje percutáneo cuando es posible. La cirugía inmediata puede ser más compleja; la necesidad de apendicectomía diferida se individualiza.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Diverticular

Subtema: Diverticulitis complicada

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 61 años con dolor en fosa iliaca izquierda, fiebre y leucocitosis. Tomografía revela diverticulitis sigmoidea con absceso pericólico de 2 cm, sin aire libre ni obstrucción.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial indicado?

- A. Antibióticos y vigilancia sin drenaje rutinario del absceso pequeño *
- B. Colectomía urgente con anastomosis en todo caso
- C. Colonoscopia durante fase aguda
- D. Laxantes y alta sin antibiótico

Explicación: Un absceso pericólico pequeño y localizado puede manejarse inicialmente con antibióticos y vigilancia clínica. Drenaje percutáneo se reserva habitualmente para colecciones mayores, y cirugía para peritonitis, fracaso o complicación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Intestinal Quirúrgica

Subtema: Obstrucción por adherencias

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 47 años con laparotomía previa presenta dolor cólico, vómito, distensión y ausencia de evacuaciones. Tomografía muestra asas delgadas dilatadas con punto de transición, sin neumatosis, ascitis ni isquemia; lactato normal.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial?

- A. Ayuno, descompresión nasogástrica, líquidos y vigilancia estrecha *
- B. Laparotomía inmediata aunque no haya datos de estrangulación
- C. Colonoscopia terapéutica
- D. Antibiótico oral y dieta baja en residuos

Explicación: La obstrucción adhesiva sin datos de isquemia o peritonitis se maneja inicialmente de forma no operatoria con reanimación, sonda y monitorización. Dolor continuo, acidosis, fiebre, leucocitosis o signos tomográficos de isquemia obligan cirugía.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Intestinal Quirúrgica

Subtema: Vólvulo de sigmoides

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 76 años institucionalizado presenta distensión masiva y dolor abdominal progresivo. Radiografía muestra signo de grano de café; tomografía no evidencia perforación ni isquemia.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial de descompresión?

- A. Detorsión endoscópica con colocación de sonda rectal *
- B. Colectomía total urgente en paciente estable
- C. Enema de bario a presión
- D. Tratamiento con neostigmina

Explicación: En vólvulo sigmoideo sin peritonitis o isquemia se intenta detorsión endoscópica con sonda rectal. Por alta recurrencia se planifica resección sigmoidea definitiva durante el mismo ingreso si es candidato.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Isquémica Intestinal

Subtema: Isquemia mesentérica aguda embólica

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 78 años con fibrilación auricular sin anticoagulación presenta dolor abdominal intenso desproporcionado a exploración de dos horas. Lactato 3.2 mmol/L, abdomen sin rigidez; angioTC muestra oclusión proximal de arteria mesentérica superior.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A. Revascularización urgente más anticoagulación y evaluación de intestino viable *
- B. Esperar peritonitis para confirmar necrosis
- C. Colonoscopia diagnóstica antes de anticoagular
- D. Antibiótico oral y observación

Explicación: El dolor desproporcionado en paciente con FA y oclusión arterial confirma isquemia mesentérica aguda. Se requiere revascularización urgente, heparina y evaluación quirúrgica del intestino; esperar signos peritoneales permite progresión a necrosis extensa.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Hernias y Esplenectomía

Subtema: Hernia inguinal incarcerada

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 64 años con hernia inguinal conocida presenta masa dolorosa irreductible de ocho horas, vómitos y distensión. Piel eritematosa sobre masa, taquicardia y lactato elevado.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta indicada?

A. Cirugía urgente por sospecha de estrangulación *

B. Reducción manual forzada y alta inmediata

C. Faja herniaria y dieta líquida

D. Colonoscopia para liberar asa atrapada

Explicación: Dolor intenso, irreductibilidad, datos sistémicos y lactato elevado sugieren estrangulación. Requiere reanimación, antibióticos y exploración urgente para reducir hernia, resecar intestino no viable y reparar defecto; la taxis puede lesionar o reducir intestino isquémico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Intestinal Inflamatoria

Subtema: Colitis ulcerosa grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 29 años con colitis ulcerosa presenta 12 evacuaciones sanguinolentas al día, fiebre, FC 118, Hb 8.7 y PCR muy elevada. Radiografía abdominal sin megacolon. Recibe esteroide intravenoso y se descarta infección.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso si no responde en tres a cinco días?

- A. Rescate con infliximab o ciclosporina tras valoración especializada *
- B. Loperamida a dosis alta
- C. Aumentar fibra dietética
- D. Alta con mesalazina tópica únicamente

Explicación: La colitis ulcerosa aguda grave exige hospitalización y esteroide intravenoso. La falta de respuesta temprana requiere terapia de rescate con infliximab o ciclosporina, y valoración quirúrgica; antidiarreicos pueden precipitar megacolon tóxico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Crohn. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Intestinal Inflamatoria

Subtema: Enfermedad de Crohn estenosante

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 27 años con Crohn ileal presenta cólicos posprandiales y vómitos. Enterorresonancia muestra estenosis ileal corta con realce inflamatorio y sin absceso; PCR elevada, sin dilatación severa.

Pregunta: ¿Cuál es el enfoque terapéutico razonable?

- A. Inducir remisión con tratamiento antiinflamatorio y reevaluar antes de cirugía *
- B. Colectomía total como primera opción
- C. Antibiótico único de por vida
- D. Endoscopia sin biopsia y alta

Explicación: La estenosis con componente inflamatorio activo puede responder a tratamiento médico para inducir remisión. La dilatación endoscópica o cirugía se consideran para estenosis fibrosas cortas o fracaso; se descarta absceso antes de inmunosupresión.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Crohn. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Hepática

Subtema: Hepatitis autoinmune

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 34 años con astenia, AST 680, ALT 720, IgG elevada, ANA 1:640 y biopsia con hepatitis de interfase. Serologías virales negativas y no consume alcohol.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de inducción habitual?

A. Prednisona con o sin azatioprina según tolerancia *

B. Interferón pegilado

C. Colecistectomía por transaminasas elevadas

D. Flebotomías semanales

Explicación: La hipergammaglobulinemia, autoanticuerpos y hepatitis de interfase apoyan hepatitis autoinmune. El tratamiento de inducción es corticoide, a menudo asociado a azatioprina como ahorrador, con monitorización de respuesta bioquímica y toxicidad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Hepática

Subtema: Esteatohepatitis metabólica

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 49 años con diabetes, obesidad central y elevación persistente de ALT. Ultrasonido reporta esteatosis; descarta alcohol significativo, hepatitis B y C. Fibrosis calculada de bajo riesgo.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención con mayor impacto comprobado?

- A. Pérdida de peso sostenida mediante alimentación y actividad física *
- B. Ácido ursodesoxicólico como única medida
- C. Antibiótico intestinal por tres meses
- D. Suspender toda actividad física para reducir transaminasas

Explicación: La enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica se maneja principalmente con reducción ponderal y ejercicio, que mejoran esteatosis y actividad inflamatoria. Se controlan diabetes, lípidos y riesgo cardiovascular, estratificando fibrosis.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Hemorragia por várices esofágicas

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre con cirrosis alcohólica llega con hematemesis, PA 88/54 y confusión. Tras proteger vía aérea y reanimación restrictiva, recibe ceftriaxona.

Pregunta: ¿Qué fármacos deben administrarse antes o junto con la endoscopia urgente?

A. Vasoactivo esplácnico como octreótido y antibiótico *

B. AINE y anticoagulación

C. Lactulosa como tratamiento hemostático único

D. Inhibidor de bomba como sustituto de vasoactivo

Explicación: En hemorragia variceal sospechada se inicia temprano vasoactivo esplácnico y profilaxis antibiótica, además de reanimación cuidadosa y ligadura endoscópica. El PPI puede usarse hasta etiología, pero no sustituye tratamiento portal específico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Peritonitis bacteriana espontánea

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer con cirrosis y ascitis es hospitalizada por dolor abdominal leve, encefalopatía y deterioro renal. Paracentesis muestra 380 PMN por mm³ y cultivo pendiente; no hay fuente quirúrgica en imagen.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inmediato?

A. Cefalosporina de tercera generación y albúmina en paciente de riesgo renal *

B. Esperar cultivo positivo para antibiótico

C. Laparotomía exploradora obligatoria

D. Diurético intensivo como único manejo

Explicación: Ascitis con PMN mayor o igual a 250 por mm³ define PBE incluso con cultivo negativo. Se inicia cefalosporina de tercera generación y, en pacientes seleccionados con alto riesgo renal, albúmina para disminuir síndrome hepatorenal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirrosis y sus Complicaciones

Subtema: Encefalopatía hepática

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre con cirrosis, somnolencia, asterixis y desorientación tiene estreñimiento de cinco días y K 2.9 mEq/L. No hay focalidad neurológica.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial dirigido al mecanismo?

A. Lactulosa titulada a dos o tres evacuaciones y corrección de precipitantes *

B. Restricción proteica absoluta indefinida

C. Sedación con benzodiacepina

D. Derivación portosistémica para bajar amonio

Explicación: La encefalopatía requiere identificar precipitantes como estreñimiento e hipokalemia. La lactulosa acidifica colon y aumenta eliminación de amonio, titulada a evacuaciones blandas; se añade rifaximina en recurrencias y se evita sedación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Arterial y Venosa

Subtema: Trombosis venosa profunda proximal

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 58 años, una semana después de artroplastía de cadera, tiene edema y dolor de pantorrilla izquierda. Ultrasonido confirma TVP femoropoplítea; está estable, sin sangrado activo y creatinina normal.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A. Anticoagulación terapéutica inmediata *
- B. Masaje profundo y medias sin anticoagulación
- C. Filtro de vena cava en todos los casos
- D. Trombólisis sistémica rutinaria

Explicación: Una TVP proximal confirmada requiere anticoagulación terapéutica salvo contraindicación. Filtro se reserva cuando no puede anticoagularse y trombólisis para casos muy seleccionados; movilización y compresión se individualizan tras iniciar tratamiento.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Arterial y Venosa

Subtema: Isquemia aguda de extremidad

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 70 años con FA presenta inicio súbito de dolor, palidez, frialdad, parestesias y ausencia de pulsos en pierna derecha hace tres horas. Aún mueve dedos con debilidad leve.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inmediata antes de revascularización?

- A. Heparina no fraccionada intravenosa *
- B. Compresión elástica intensa
- C. Warfarina oral como única intervención
- D. Aspirina y cita en una semana

Explicación: Las seis P sugieren isquemia aguda por émbolo. La heparina intravenosa evita propagación mientras se clasifica viabilidad y se realiza embolectomía, trombólisis dirigida o cirugía; retraso amenaza extremidad y vida.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Patología Perianal

Subtema: Absceso perianal

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 36 años con dolor anal pulsátil, fiebre y masa fluctuante perianal de 3 cm. No tiene neutropenia ni enfermedad de Crohn conocida.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento definitivo inicial?

A. Incisión y drenaje oportunos *

B. Antibiótico oral como único manejo

C. Hemorroidec tomía electiva

D. Escleroterapia de la colección

Explicación: El absceso anorrectal requiere drenaje, pues los antibióticos solos no penetran una colección. Se añaden antibióticos en celulitis extensa, diabetes, inmunosupresión o sepsis; se da seguimiento por posible fístula.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Urología

Subtema: Cólico renal complicado

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 41 años con dolor cólico en flanco, fiebre de 39 C, taquicardia y creatinina 1.8. Tomografía muestra cálculo ureteral proximal de 8 mm con hidronefrosis.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta urgente?

A. Descomprimir vía urinaria con catéter ureteral o nefrostomía y antibióticos *

B. Expulsión médica ambulatoria con tamsulosina

C. Litotricia extracorpórea inmediata sin drenaje

D. Analgésicos y reevaluación en 72 horas

Explicación: La obstrucción ureteral infectada es una urgencia urológica. Requiere antibióticos y descompresión rápida por stent o nefrostomía; la extracción definitiva del cálculo se realiza cuando la sepsis se controla.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Urología

Subtema: Hiperplasia prostática benigna

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 72 años con síntomas obstructivos severos, residuo posmiccional de 260 mL y dos episodios de retención. Tacto rectal con próstata aumentada lisa; PSA ajustado a volumen sin sospecha de cáncer.

Pregunta: ¿Qué fármaco reduce progresión y riesgo de retención si la próstata es grande?

A. Inhibidor de 5 alfa reductasa *

B. Antibiótico fluoroquinolona crónico

C. Anticolinérgico como monoterapia en alto residuo

D. Diurético de asa nocturno

Explicación: En HBP con próstata grande, un inhibidor de 5 alfa reductasa reduce volumen y progresión, con efecto gradual; puede combinarse con alfa bloqueador para alivio rápido. Anticolinérgicos se usan con cautela si hay alto residuo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Urología

Subtema: Cáncer de próstata y PSA elevado

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 66 años, asintomático, PSA aumenta de 4.2 a 7.8 ng/mL en un año. No hay infección urinaria, tacto rectal con nódulo duro periférico y expectativa de vida mayor de diez años.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico?

- A. Resonancia multiparamétrica y biopsia dirigida o sistemática según resultado *
- B. Iniciar hormonoterapia sin histología
- C. Repetir PSA en cinco años
- D. Resección transuretral diagnóstica como primera elección

Explicación: Un PSA en ascenso con nódulo sospechoso requiere evaluación para cáncer clínicamente significativo. La resonancia multiparamétrica orienta biopsia dirigida y disminuye detección de enfermedad irrelevante; no se inicia tratamiento definitivo sin confirmación tisular.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: ETS

Subtema: Sífilis primaria

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 28 años con úlcera genital única, indurada, limpia e indolora y adenopatías inguinales no dolorosas. RPR reactivo 1:64 y prueba treponémica positiva; no hay síntomas neurológicos.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- A. Penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única *
- B. Azitromicina de una sola toma como alternativa preferida
- C. Ceftriaxona tópica
- D. Aciclovir intravenoso

Explicación: El chancro indoloro con serología confirma sífilis primaria. La penicilina G benzatínica intramuscular es tratamiento de primera línea; se notifican y tratan parejas, se ofrece prueba de VIH y se vigila respuesta serológica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: ATLS

Subtema: Trauma torácico con neumotórax a tensión

Dificultad: alta

Caso clínico: Tras lesión penetrante en tórax, hombre de 24 años está hipotenso, con disnea extrema, desviación traqueal, yugulares ingurgitadas y ausencia de ruidos respiratorios derechos.

Pregunta: ¿Cuál es la acción inmediata?

- A. Descompresión torácica inmediata seguida de tubo pleural *
- B. Esperar radiografía de tórax portátil
- C. Intubación antes de tratar tórax
- D. Pericardiocentesis por defecto

Explicación: El neumotórax a tensión es diagnóstico clínico y causa choque obstructivo. Debe descomprimirse de inmediato y colocarse tubo de tórax sin retraso por imagen; la ventilación a presión positiva sin descompresión puede precipitar colapso.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: ATLS

Subtema: Trauma craneoencefálico

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 31 años tras choque tiene Glasgow 7, vómito y anisocoria izquierda. PA 150/70, FC 52 y respiración irregular. Tomografía disponible en 10 minutos.

Pregunta: ¿Cuál es la prioridad en evaluación primaria?

- A. Asegurar vía aérea con protección cervical y ventilación *
- B. Esperar tomografía antes de intubar
- C. Administrar hipotónicos para edema cerebral
- D. Punción lumbar por sospecha de hemorragia

Explicación: Glasgow menor o igual a 8 obliga proteger vía aérea, manteniendo inmovilización cervical y evitando hipoxemia e hipotensión, los principales daños secundarios. Tomografía se realiza tras estabilización, sin demorar manejo ABC.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: ATLS

Subtema: Trauma abdominal cerrado

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 26 años con choque tras colisión, FAST positivo en espacio hepatorrenal y abdomen distendido. No responde a reanimación inicial.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta indicada?

- A. Laparotomía exploradora inmediata *
- B. Tomografía abdominal con contraste
- C. Observación seriada en urgencias
- D. Lavado peritoneal diagnóstico antes de decidir

Explicación: Paciente inestable con FAST positivo tiene hemoperitoneo hasta demostrar lo contrario y requiere laparotomía para control de hemorragia. La tomografía se reserva para pacientes estables o respondedores transitorios cuidadosamente seleccionados.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Intoxicaciones y Picaduras

Subtema: Alacranismo grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Niño de cuatro años tras picadura de alacrán presenta sialorrea, nistagmo, fasciculaciones linguales, taquicardia y dificultad respiratoria. El evento ocurrió en zona endémica y han pasado 45 minutos.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento específico?

A. Faboterápico polivalente antialacrán intravenoso *

B. Antihistamínico oral como única medida

C. Antibiótico antitetánico exclusivo

D. Torniquete proximal y hielo directo

Explicación: Las manifestaciones neurológicas, autonómicas y respiratorias indican alacranismo moderado o grave. El faboterápico específico debe administrarse precozmente junto con soporte de vía aérea y vigilancia; torniquetes e incisiones son dañinos.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Intoxicaciones y Picaduras

Subtema: Mordedura de serpiente

Dificultad: alta

Caso clínico: Trabajador rural llega 90 minutos tras mordedura de víbora con edema progresivo que cruza una articulación, equimosis y fibrinógeno bajo. No tiene hipotensión todavía.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención específica indicada?

A. Faboterápico antiviperino según grado de envenenamiento *

B. Antibiótico profiláctico como tratamiento único

C. Incisiones en sitio de mordedura

D. Prueba de torniquete y alta si es positiva

Explicación: El edema progresivo y coagulopatía son envenenamiento viperino sistémico. El faboterápico neutraliza veneno circulante y se administra temprano, monitorizando coagulación y extremidad; no se hacen incisiones, succión ni torniquetes.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Quemaduras, Golpe de Calor e Hipotermia

Subtema: Quemadura inhalatoria

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre rescatado de incendio en espacio cerrado tiene cejas chamuscadas, esputo carbonáceo, voz ronca y quemaduras faciales. Saturación convencional es 99 por ciento con oxígeno, pero está inquieto.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta prioritaria?

- A. Intubación temprana antes de edema progresivo de vía aérea *
- B. Dar alta por saturación normal
- C. Esperar estridor para proteger vía aérea
- D. Usar solo broncodilatador inhalado

Explicación: El daño térmico de vía aérea puede progresar rápidamente; quemaduras faciales, hollín y disfonía justifican intubación temprana. La oximetría no detecta carboxihemoglobina, por lo que se administra oxígeno al 100 por ciento y se mide cooximetría.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirugía Oncológica

Subtema: Cáncer de colon derecho

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 68 años con anemia ferropénica, pérdida de peso y prueba inmunoquímica fecal positiva. Colonoscopia identifica masa ulcerada en ciego; biopsia muestra adenocarcinoma. Tomografía no muestra metástasis.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento curativo inicial?

A. Hemicolectomía derecha oncológica con linfadenectomía adecuada *

B. Quimioterapia exclusiva sin resección

C. Radioterapia pélvica preoperatoria

D. Polipectomía endoscópica de masa infiltrante

Explicación: El adenocarcinoma de colon localizado se trata con resección oncológica del segmento y drenaje linfático regional. La estadificación patológica orienta quimioterapia adyuvante; radioterapia tiene papel principal en recto, no colon derecho.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Cirugía Oncológica

Subtema: Cáncer de recto localmente avanzado

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 57 años con adenocarcinoma rectal a 5 cm del margen anal, T3N1 por resonancia, sin metástasis. Tiene buen estado funcional.

Pregunta: ¿Cuál es una estrategia estándar de manejo multidisciplinario?

A. Terapia neoadyuvante y resección total del mesorrecto *

B. Hemicolectomía derecha inmediata

C. Radioterapia aislada sin cirugía

D. Polipectomía transanal simple

Explicación: El cáncer de recto localmente avanzado requiere planeación con resonancia y equipo multidisciplinario. La quimiorradiación o terapia neoadyuvante total seguida de resección total del mesorrecto mejora control local y permite considerar preservación de esfínter.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal. Vigente.

Especialidad: Cirugía

Tema: Oftalmología

Subtema: Glaucoma agudo de ángulo cerrado

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 63 años con dolor ocular intenso, halos, náusea, córnea edematosa, pupila media fija y presión intraocular de 54 mmHg.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial?

A. Reducir presión intraocular urgentemente y realizar iridotomía láser cuando córnea lo permita *

B. Parche ocular y cita diferida

C. Antibiótico tópico como único manejo

D. Dilatar pupila para explorar fondo de ojo

Explicación: El glaucoma agudo de ángulo cerrado amenaza visión en horas. Se baja presión con agentes tópicos y sistémicos según contraindicaciones, se usa pilocarpina cuando respuesta lo permite y se practica iridotomía láser en ojo afectado y profiláctica en contralateral.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Introducción e Infectología

Subtema: Choque séptico

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 68 años con pielonefritis obstructiva tiene fiebre, confusión, lactato 5.1 mmol/L y PA 76/42 pese a recibir 30 mL/kg de cristaloides balanceados. Se toman hemocultivos y recibe antibiótico de amplio espectro.

Pregunta: ¿Cuál es el vasopresor inicial de elección?

- A. Norepinefrina *
- B. Dopamina a dosis renal
- C. Fenilefrina como primera línea universal
- D. Vasopresina como único agente inicial

Explicación: La hipotensión persistente tras reanimación adecuada define choque séptico. Norepinefrina es el vasopresor inicial recomendado para alcanzar PAM de al menos 65 mmHg; se añade vasopresina o epinefrina si se requiere, mientras se controla foco urinario.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones Específicas

Subtema: Tuberculosis pulmonar

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 36 años con tos de seis semanas, pérdida de peso, diaforesis nocturna y hemoptisis leve. Baciloscopias seriadas son negativas, pero prueba molecular en esputo detecta M tuberculosis sin resistencia a rifampicina.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta apropiada?

A. Iniciar tratamiento antituberculoso y estudio de contactos *

B. Descartar tuberculosis porque la baciloscopia fue negativa

C. Dar fluoroquinolona aislada por neumonía atípica

D. Esperar cultivo durante ocho semanas sin tratar

Explicación: Una prueba molecular positiva confirma tuberculosis aun con baciloscopias negativas y puede informar resistencia a rifampicina. Se inicia esquema de primera línea conforme al programa, se notifica, evalúan contactos y se investiga coinfección por VIH.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-070-08, Tuberculosis pulmonar. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones Específicas

Subtema: Dengue con signos de alarma

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 24 años, día cuatro de fiebre y mialgias, presenta dolor abdominal intenso, vómito persistente, hemoconcentración y plaquetas en descenso. No hay choque aún, hematocrito aumenta respecto a basal.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo indicado?

A. Hospitalización y líquidos isotónicos guiados por estado hemodinámico *

B. Aspirina por plaquetopenia

C. AINE para dolor articular intenso

D. Alta con solución hipotónica sin vigilancia

Explicación: Dolor abdominal, vómito persistente y hemoconcentración son signos de alarma por fuga plasmática. Se hospitaliza y se administran cristaloides isotónicos con ajustes por perfusión, hematocrito y diuresis; se evitan AINE y aspirina por riesgo hemorrágico.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones Específicas

Subtema: VIH con neumonía por Pneumocystis

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 32 años sin tratamiento antirretroviral tiene disnea subaguda, tos seca, hipoxemia, LDH elevada e infiltrados intersticiales bilaterales. CD4 es 68 células por mm³ y PaO₂ 62 mmHg.

Pregunta: ¿Cuál es el esquema inicial más apropiado?

- A. Trimetoprim sulfametoxazol más corticoide sistémico *
- B. Amoxicilina aislada por neumonía comunitaria
- C. Fluconazol como monoterapia
- D. Antirretroviral inmediato sin tratar infección oportunista

Explicación: El cuadro subagudo con CD4 bajo sugiere neumonía por Pneumocystis. Se trata con trimetoprim sulfametoxazol; la hipoxemia importante indica corticoide adyuvante. El inicio de antirretroviral se coordina tras valorar infección oportunista e interacciones.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-234-09, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: EPOC exacerbado con acidosis

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 71 años con EPOC grave presenta aumento de disnea, esputo purulento y somnolencia. Gasometría: pH 7.28, PaCO₂ 68 mmHg, PaO₂ 55 mmHg con oxígeno controlado; está cooperador y protege vía aérea.

Pregunta: ¿Cuál es el soporte ventilatorio inicial indicado?

- A. Ventilación no invasiva con presión positiva *
- B. Oxígeno a alto flujo sin objetivo de saturación
- C. Intubación obligatoria en todo paciente hipercápnico
- D. Sedación y observación

Explicación: La exacerbación con acidosis respiratoria hipercápnica en paciente cooperador es indicación de ventilación no invasiva, que disminuye intubación y mortalidad. Se titula oxígeno a 88 a 92 por ciento, se dan broncodilatadores, corticoide y antibiótico si corresponde.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-234-09, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: Derrame pleural parapneumónico complicado

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 50 años con neumonía persiste febril pese a antibióticos. Toracocentesis obtiene líquido turbio con pH 7.08, glucosa 38 mg/dL, DHL alta y cultivo positivo; ultrasonido muestra tabiques.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso?

- A. Drenaje pleural con tubo más antibióticos *
- B. Toracocentesis repetida como único tratamiento
- C. Diurético por derrame inflamatorio
- D. Observación porque el volumen es moderado

Explicación: Un pH menor de 7.20, glucosa baja, pus o cultivo positivo definen derrame complicado que requiere drenaje además de antibióticos. Los tabiques pueden requerir fibrinolíticos intrapleurales o cirugía según respuesta.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-234-09, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis diabética

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 23 años con DM1 omite insulina por gastroenteritis. Glucosa 420 mg/dL, pH 7.12, bicarbonato 9 mEq/L, anion gap elevado y K 5.4 mEq/L. Está deshidratada, consciente y sin infección grave.

Pregunta: ¿Cuál es el primer paso terapéutico?

A. Solución isotónica intravenosa y evaluación de potasio antes de insulina *

B. Bicarbonato intravenoso inmediato por pH menor de 7.2

C. Insulina en bolo antes de líquidos

D. Restringir líquidos para evitar edema cerebral

Explicación: La prioridad en cetoacidosis es restaurar volumen con cristaloides y vigilar potasio. La insulina se inicia después de verificar que potasio no esté peligrosamente bajo; bicarbonato se reserva para acidosis extrema. Se identifica y trata el precipitante.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-718-18, Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Estado hiperosmolar hiperglucémico

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 77 años con DM2 y neumonía llega deshidratado, obnubilado, glucosa 870 mg/dL, osmolaridad efectiva 345 mOsm/kg, pH 7.36 y cetonas mínimas.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más importante?

- A. Reposición vigorosa pero vigilada con solución isotónica *
- B. Insulina en bolo alto antes de líquidos
- C. Bicarbonato intravenoso para corregir osmolaridad
- D. Diálisis urgente por glucosa elevada

Explicación: El estado hiperosmolar cursa con déficit hídrico profundo y mínima cetosis. La reposición de volumen es prioritaria y reduce glucosa por sí misma; insulina se añade a dosis baja cuando se ha iniciado reanimación y se monitorizan sodio y potasio.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-718-18, Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Enfermedad de Graves

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 29 años con pérdida de peso, temblor, bocio difuso con soplo, oftalmopatía activa y TSH suprimida presenta T4 libre elevada. No está embarazada y no tiene hepatopatía.

Pregunta: ¿Cuál es el fármaco antitiroideo de primera línea fuera del primer trimestre?

A. Metimazol *

B. Levotiroxina

C. Yodo radioactivo inmediato con oftalmopatía activa

D. Propranolol como único tratamiento definitivo

Explicación: La clínica y bioquímica indican Graves. Fuera del primer trimestre, metimazol es el antitiroideo de elección y un beta bloqueador controla síntomas. El radioyodo puede empeorar oftalmopatía activa y requiere valoración individual.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-514-11, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Graves en mayores de 18 años. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Hipotiroidismo primario

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 45 años con fatiga, constipación, piel seca y TSH 18 mUI/L con T4 libre baja. No tiene cardiopatía isquémica ni embarazo; toma calcio al desayuno.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A. Levotiroxina en ayuno, separada de calcio y con control de TSH *

B. Liotironina intravenosa crónica

C. Yodo inorgánico como única medida

D. Metimazol a dosis baja

Explicación: TSH elevada con T4 baja confirma hipotiroidismo primario. Levotiroxina es tratamiento de elección; debe tomarse en ayuno y separarse de calcio o hierro para evitar mala absorción. Se ajusta por TSH tras varias semanas.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-265-10, Hipotiroidismo primario en el adulto. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Hiperprolactinemia por prolactinoma

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 30 años con amenorrea, galactorrea y cefalea presenta prolactina 185 ng/mL. Embarazo, hipotiroidismo y fármacos antidopaminérgicos se excluyeron; resonancia muestra microadenoma de 6 mm sin alteración campimétrica.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A. Agonista dopaminérgico como cabergolina *
- B. Cirugía transesfenoidal inmediata en todo microadenoma
- C. Anticonceptivo sin estudiar causa
- D. Radioterapia hipofisaria inicial

Explicación: La hiperprolactinemia persistente con microadenoma se trata inicialmente con agonista dopaminérgico, preferentemente cabergolina por eficacia y tolerabilidad. La cirugía se reserva para resistencia, intolerancia o compresión significativa.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-644-13, Diagnóstico de hiperprolactinemia. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Anemia ferropénica en adulto

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 59 años con Hb 8.9 g/dL, VCM 70 fL, ferritina 6 ng/mL y pérdida de peso niega sangrado visible. No toma AINE y no tiene dieta restrictiva.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta diagnóstica obligada además de reponer hierro?

- A. Buscar sangrado gastrointestinal con endoscopia y colonoscopia *
- B. Atribuir anemia a dieta y controlar en un año
- C. Transfundir de rutina hasta Hb normal
- D. Solicitar médula ósea como primer estudio

Explicación: La anemia ferropénica en hombre adulto es sangrado gastrointestinal hasta demostrar lo contrario, incluso sin síntomas. Se repone hierro y se investiga con evaluación endoscópica alta y baja según el caso para excluir neoplasia u otra lesión.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Anemia megaloblástica por B12

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 63 años con parestesias, marcha inestable, glositis, Hb 8.1, VCM 112 y neutrófilos hipersegmentados. B12 baja, folato normal y anticuerpos anti factor intrínseco positivos.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento adecuado?

A. Reposición de cobalamina, habitualmente parenteral al inicio *

B. Ácido fólico aislado en dosis alta

C. Hierro intravenoso como único manejo

D. Transfusión crónica sin reemplazo vitamínico

Explicación: La anemia perniciosa produce déficit de B12 y manifestaciones neurológicas. Debe reponerse cobalamina, con vía parenteral inicial si hay malabsorción o síntomas neurológicos; folato aislado puede corregir anemia mientras permite progresión neurológica.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Infarto con elevación de ST

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 58 años con dolor opresivo de 90 minutos, ST elevado en II, III y aVF, PA 110/70 y sin contraindicación a reperfusión. El centro cuenta con hemodinamia y tiempo estimado puerta dispositivo de 75 minutos.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia de reperfusión preferida?

- A. Intervención coronaria percutánea primaria *
- B. Fibrinólisis aunque PCI sea oportuna
- C. Esperar troponina de control antes de reperfundir
- D. Aspirina sola y prueba de esfuerzo posterior

Explicación: En IAM con elevación de ST dentro de ventana y posibilidad de intervención en tiempo adecuado, la PCI primaria es la estrategia preferida. Se administran antiagregantes y anticoagulación conforme protocolo sin retrasar reperfusión.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Insuficiencia cardiaca con fracción reducida

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 62 años con FEVI 30 por ciento, NYHA II, euvolémico tras infarto antiguo. Usa enalapril y carvedilol a dosis toleradas; eGFR 58 y K 4.5.

Pregunta: ¿Qué fármaco reduce mortalidad y hospitalización al añadirlo?

A. Antagonista de receptor mineralocorticoide *

B. Verapamilo para aumentar contractilidad

C. AINE para disnea residual

D. Diltiazem como terapia de base

Explicación: En IC con fracción reducida sintomática pese a IECA y beta bloqueador, un antagonista mineralocorticoide reduce mortalidad si función renal y potasio lo permiten. Debe vigilarse hiperpotasemia y creatinina después de iniciarlo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Fibrilación auricular no valvular

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 74 años con FA paroxística, hipertensión y antecedente de AIT, sin estenosis mitral ni prótesis mecánica. eGFR 65, sin sangrado activo.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia para prevención de EVC?

A. Anticoagulación oral a largo plazo *

B. Aspirina como sustituto equivalente

C. No tratar por ser FA paroxística

D. Cardioversión eléctrica semanal sin anticoagulación

Explicación: El riesgo tromboembólico es alto por edad, hipertensión y AIT, independientemente de que la FA sea paroxística. En FA no valvular se indica anticoagulación oral tras valorar sangrado; aspirina no ofrece protección equivalente.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Pericarditis aguda

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 34 años con dolor torácico que mejora al sentarse, roce pericárdico y elevación difusa de ST con depresión de PR. Troponina mínimamente elevada, sin derrame significativo ni inestabilidad.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial?

A. AINE más colchicina y restricción de ejercicio *

B. Anticoagulación plena por elevación de ST

C. Fibrinólisis urgente

D. Antibiótico de amplio espectro sin otros estudios

Explicación: Dolor posicional, roce y cambios electrocardiográficos difusos indican pericarditis aguda no complicada. El tratamiento es AINE más colchicina, con protección gástrica y restricción de ejercicio; se busca etiología y datos de alto riesgo.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-463-11, Diagnóstico y tratamiento de pericarditis en el adulto. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: EVC isquémico agudo

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 67 años inicia afasia y hemiparesia derecha hace 110 minutos. NIHSS 14, TC sin hemorragia ni hipodensidad extensa, PA 174/96 y glucosa 118. No toma anticoagulantes.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención de reperfusión indicada?

- A. Trombólisis intravenosa si no hay contraindicaciones, con evaluación de trombectomía *
- B. Aspirina y observación hasta mañana
- C. Heparina intravenosa a dosis plena como primera línea
- D. Disminuir PA a menos de 120/80 antes de todo tratamiento

Explicación: Está dentro de ventana para trombólisis y tiene déficit incapacitante con TC sin sangrado. Se administra alteplasa o tenecteplasa conforme protocolo, controlando PA debajo de umbral, y se realiza angioimagen para valorar trombectomía si existe oclusión de gran vaso.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Hemorragia intracerebral asociada a anticoagulante

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 76 años con FA en warfarina, INR 3.4, presenta cefalea súbita, hemiparesia y TC con hemorragia gangliobasal de 35 mL.

Pregunta: ¿Cuál es la medida urgente de reversión?

- A. Complejo protrombínico de cuatro factores más vitamina K intravenosa *
- B. Aspirina para estabilizar plaquetas
- C. Heparina para evitar tromboembolismo
- D. Solo suspender warfarina y observar INR

Explicación: En hemorragia intracerebral asociada a warfarina se revierte INR rápidamente con complejo protrombínico de cuatro factores y vitamina K intravenosa. La rapidez limita expansión del hematoma; se controla PA y se valora neurocirugía.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Síndrome de Guillain Barré

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 28 años, una semana tras diarrea, desarrolla debilidad ascendente simétrica, arreflexia y parestesias.

Capacidad vital disminuye de 3.2 a 1.7 L en seis horas, sin alteración sensitiva central.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta prioritaria?

A. Ingreso a unidad con vigilancia respiratoria y administrar inmunoglobulina o plasmaféresis *

B. Corticoide oral aislado

C. Alta con fisioterapia ambulatoria

D. Antibiótico contra *Campylobacter* como tratamiento neurológico

Explicación: El Guillain Barré puede evolucionar rápido a falla respiratoria y disautonomía. El descenso de capacidad vital exige vigilancia en unidad; inmunoglobulina o plasmaféresis acelera recuperación. Los corticoides no han demostrado beneficio.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Miastenia gravis

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 38 años con ptosis fluctuante, diplopía y debilidad que empeora al final del día. Anticuerpos anti receptor de acetilcolina positivos; TC de tórax sin timoma.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento sintomático inicial?

- A. Piridostigmina *
- B. Levodopa carbidopa
- C. Haloperidol
- D. Acetazolamida

Explicación: La fatigabilidad ocular y anticuerpos confirman miastenia. Piridostigmina mejora transmisión neuromuscular y es tratamiento sintomático inicial; se evalúa inmunoterapia según gravedad y se evita fármacos que empeoran la unión neuromuscular.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Dermatología

Subtema: Síndrome de Stevens Johnson

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 27 años inicia lamotrigina hace dos semanas y desarrolla fiebre, máculas dolorosas violáceas, ampollas y erosiones en mucosa oral y ocular, con desprendimiento epidérmico de 8 por ciento.

Pregunta: ¿Cuál es la acción inmediata más importante?

- A. Suspender el fármaco causal y manejar en unidad especializada *
- B. Continuar lamotrigina con antihistamínico
- C. Dar antibiótico tópico y alta
- D. Realizar pruebas de parche durante fase aguda

Explicación: La afectación mucocutánea dolorosa tras fármaco nuevo es Stevens Johnson. La medida de mayor impacto es retirar de inmediato el medicamento causal, brindar soporte como gran quemado y valorar oftalmología, piel y unidad especializada.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Dermatología

Subtema: Psoriasis en placas moderada grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 40 años con placas eritematoescamosas en 15 por ciento de superficie corporal, prurito y artralgia inflamatoria de dedos. No tiene infección activa ni hepatopatía. Tratamientos tópicos adecuados han fracasado.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente escalón razonable?

- A. Valoración para terapia sistémica que cubra piel y articulaciones *
- B. Corticoide sistémico prolongado como tratamiento de elección
- C. Antibiótico oral crónico
- D. Suspender toda actividad física

Explicación: La extensión significativa, fracaso tópico y sospecha de artritis psoriásica requieren valoración dermatológica reumatológica para fototerapia o terapia sistémica. Los corticoides sistémicos pueden provocar rebote y no son tratamiento estándar sostenido.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Artritis reumatoide temprana

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 42 años con sinovitis simétrica de metacarpofalángicas y muñecas por cuatro meses, rigidez matutina de dos horas, anti CCP positivo y erosiones iniciales. No planea embarazo y pruebas hepáticas son normales.

Pregunta: ¿Cuál es el fármaco modificador inicial de elección?

- A. Metotrexato semanal con ácido fólico *
- B. Prednisona crónica como monoterapia
- C. Paracetamol como tratamiento modificador
- D. Alopurinol para erosiones

Explicación: La artritis reumatoide temprana seropositiva requiere un FAME de inicio temprano para evitar daño irreversible. Metotrexato es el ancla terapéutica si no hay contraindicación, con ácido fólico, anticoncepción y monitorización hematológica y hepática.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Lupus eritematoso sistémico con nefritis

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 24 años con LES tiene edema, proteinuria de 3.8 g al día, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, creatinina 1.4 y complemento bajo.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso para guiar inmunosupresión?

- A. Biopsia renal para clasificar nefritis lúpica *
- B. Aumentar solo hidroxicloroquina sin estudio renal
- C. Diurético y repetir examen en un año
- D. Anticoagulación por proteinuria sin evaluación

Explicación: El sedimento activo, proteinuria significativa y deterioro renal sugieren nefritis lúpica. La biopsia renal clasifica lesión y define intensidad de inducción, además de excluir procesos concomitantes; se controlan PA, proteinuria e hidroxicloroquina.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Arteritis de células gigantes

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 73 años con cefalea temporal nueva, claudicación mandibular, VSG 98 y episodios de amaurosis fugaz. Arteria temporal dolorosa y engrosada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A. Glucocorticoide a dosis alta sin esperar biopsia *
- B. Esperar biopsia para iniciar tratamiento
- C. Aspirina como tratamiento único
- D. Antibiótico por arteritis infecciosa

Explicación: La pérdida visual puede ser irreversible en arteritis de células gigantes. La sospecha alta obliga iniciar glucocorticoide de inmediato y solicitar biopsia o imagen sin demorar el tratamiento; se vigilan complicaciones aórticas y respuesta inflamatoria.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefrología

Subtema: Lesión renal aguda prerrenal

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 70 años con gastroenteritis y uso de IECA tiene creatinina de 2.1 desde basal 0.9, mucosas secas, FeNa 0.4 por ciento, sedimento hialino y ecografía sin hidronefrosis.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial?

- A. Restituir volumen y suspender temporalmente nefrotóxicos *
- B. Biopsia renal urgente
- C. Diurético de asa para aumentar filtración
- D. Contraste intravenoso para evaluar riñones

Explicación: La hipovolemia, FeNa baja y sedimento blando apoyan lesión prerrenal. Se restauran líquidos y perfusión, se suspenden IECA y otros nefrotóxicos, y se monitoriza diuresis y creatinina; la biopsia no es inicial en patrón claro.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefrología

Subtema: Síndrome nefrótico

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 35 años con edema generalizado, albúmina 2.1 g/dL, proteinuria 6 g al día e hipercolesterolemia presenta dolor súbito en flanco y hematuria.

Pregunta: ¿Qué complicación debe sospecharse y buscarse?

- A. Trombosis de vena renal *
- B. Glomerulonefritis postestreptocócica aislada
- C. Pielonefritis no complicada
- D. Apendicitis

Explicación: El síndrome nefrótico genera estado de hipercoagulabilidad por pérdida de antitrombina y otros factores. Dolor de flanco y hematuria sugieren trombosis de vena renal, que debe confirmarse con imagen apropiada y tratarse con anticoagulación si no hay contraindicación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Psiquiatría

Subtema: Delirium tremens

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 49 años, 72 horas después de hospitalización sin alcohol, presenta desorientación, agitación, alucinaciones visuales, diaforesis, HTA y temblor grueso. No hay focalidad ni fiebre.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A. Benzodiacepina titulada a sedación ligera y tiamina *
- B. Haloperidol como monoterapia
- C. Restricción física sin fármacos
- D. Naltrexona intravenosa aguda

Explicación: El delirium tremens es abstinencia alcohólica grave y potencialmente mortal. Las benzodiacepinas tituladas son primera línea; se administra tiamina antes de glucosa, se corrigen electrolitos y se vigila en ambiente monitorizado.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Psiquiatría

Subtema: Esquizofrenia con riesgo suicida

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 22 años con delirios persecutorios y alucinaciones auditivas imperativas de hacerse daño tiene plan suicida activo. Consumo de sustancias se descartó y está acompañado por familia.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inmediata?

A. Hospitalización psiquiátrica para seguridad y tratamiento antipsicótico *

B. Alta con cita ambulatoria en un mes

C. Benzodiacepina aislada sin evaluación de riesgo

D. Confrontar directamente sus delirios y dejarlo solo

Explicación: Psicosis con mandato autolesivo y plan suicida implica riesgo inminente. Debe asegurarse ambiente protegido, evaluación integral y tratamiento antipsicótico; la atención ambulatoria no proporciona contención suficiente en este momento.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Geriátría

Subtema: Delirium hipoactivo

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 84 años con demencia leve, hospitalizada por fractura, se vuelve somnolienta, inatenta y desorientada de inicio súbito tras recibir opioides. Antes conversaba y reconocía familiares.

Pregunta: ¿Cuál es la medida inicial más importante?

- A. Buscar y corregir precipitantes, revisar fármacos y aplicar medidas no farmacológicas *
- B. Aumentar sedantes para que descanse
- C. Atribuirlo a progresión normal de demencia
- D. Restringir líquidos para prevenir edema cerebral

Explicación: El cambio agudo y fluctuante de atención es delirium, incluso hipoactivo. Se buscan dolor, infección, hipoxia, retención, estreñimiento y fármacos; la reorientación, sueño, movilidad y lentes o audífonos son pilares, reservando fármacos para riesgo grave.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Epidemiología

Subtema: Valor predictivo positivo

Dificultad: alta

Caso clínico: En un programa de tamizaje de baja prevalencia se utiliza prueba con sensibilidad 95 por ciento y especificidad 90 por ciento. La prevalencia real de enfermedad es 1 por ciento.

Pregunta: ¿Cuál afirmación es correcta?

- A. El valor predictivo positivo será mucho menor que la sensibilidad *
- B. Un resultado positivo confirma enfermedad en 95 por ciento de casos
- C. La especificidad no influye en falsos positivos
- D. La prevalencia no modifica valores predictivos

Explicación: Con prevalencia baja, aun una prueba sensible y específica genera numerosos falsos positivos en relación con verdaderos positivos. Por ello el valor predictivo positivo es inferior a sensibilidad y suele requerirse prueba confirmatoria.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Hipertensión arterial con urgencia hipertensiva

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 58 años con PA 210/118, cefalea leve y ansiedad. Fondo de ojo sin papiledema, creatinina y troponina normales, TC cerebral sin evento agudo, no hay edema pulmonar ni disección.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo correcto?

- A. Reducir PA gradualmente con fármaco oral y seguimiento cercano *
- B. Bajar PA a normal en minutos con nitroprusiato
- C. Trombólisis por cifra elevada
- D. No tratar porque no hay daño agudo

Explicación: Sin daño agudo a órgano blanco se trata de urgencia hipertensiva, no emergencia. La PA se reduce gradualmente con tratamiento oral y ajuste crónico; descensos bruscos pueden comprometer perfusión cerebral, coronaria o renal.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-076-08, Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Obesidad y semaglutida

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 38 años, IMC 37 kg/m², hipertensión y apnea del sueño ha realizado intervención nutricional y actividad estructurada durante seis meses con pérdida insuficiente. No hay embarazo ni antecedente de pancreatitis.

Pregunta: ¿Cuál es un criterio que apoya agregar farmacoterapia para peso?

- A. IMC mayor o igual a 30 con comorbilidades y fracaso de medidas intensivas *
- B. Deseo estético con IMC de 21
- C. Uso simultáneo de dos agonistas GLP 1
- D. Embarazo activo con hiperemesis

Explicación: La obesidad con comorbilidades puede requerir farmacoterapia como complemento de cambios intensivos cuando no se alcanzan metas. Se individualiza según contraindicaciones, efecto metabólico, costo y seguimiento; no se usa como sustituto de dieta y actividad.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. GPC-IMSS-046-18, Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: Neumonía adquirida en comunidad grave

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 66 años con fiebre, confusión, FR 34, PA 86/52, urea elevada y infiltrado multilobar requiere vasopresor tras líquidos.

Pregunta: ¿Cuál es el sitio de atención apropiado?

- A. Unidad de cuidados intensivos con antibiótico empírico temprano *
- B. Manejo ambulatorio con macrólido
- C. Observación en casa por 48 horas
- D. Antibiótico oral sin monitorización

Explicación: Choque, taquipnea, confusión e infiltrados multilobares son criterios de neumonía grave. Requiere UCI, cultivos sin retrasar antibiótico temprano, soporte ventilatorio y hemodinámico, y reevaluación de cobertura según microbiología.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-234-09, Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones Específicas

Subtema: Tétanos

Dificultad: alta

Caso clínico: Hombre de 44 años sin esquema vacunal completo consulta por trismo, rigidez abdominal y espasmos dolorosos ocho días después de punción plantar contaminada. Está consciente y sin herida supurada evidente.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo específico integral?

A. Inmunoglobulina antitetánica, desbridamiento, metronidazol y control de espasmos *

B. Toxoide tetánico aislado como único tratamiento

C. Penicilina tópica y alta

D. Antitoxina diftérica

Explicación: El tétanos clínico exige inmunoglobulina para neutralizar toxina libre, limpieza y desbridamiento de puerta de entrada, antibiótico como metronidazol, soporte de vía aérea y control de espasmos. La enfermedad no confiere inmunidad, por lo que se completa vacunación.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS-070-08, Tuberculosis pulmonar. Vigente.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Púrpura trombocitopénica trombótica

Dificultad: alta

Caso clínico: Mujer de 35 años presenta petequias, confusión, creatinina 1.6, Hb 7.9, plaquetas 18,000, esquistocitos y DHL alta. TP y TTPa son normales.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta que no debe esperar el resultado de ADAMTS13?

- A. Plasmaféresis urgente y corticoide *
- B. Transfusión profiláctica de plaquetas
- C. Heparina terapéutica
- D. Esplenectomía inmediata

Explicación: La combinación de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia con coagulación normal sugiere PTT. La mortalidad es alta sin plasmaféresis, por lo que se inicia de inmediato junto con corticoide y se envía ADAMTS13; plaquetas se evitan salvo hemorragia amenazante.

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Guías de Práctica Clínica, catálogo institucional en línea. Consulta vigente: 2026.